G3 — Soif excessive, polydipsie · Entraînement Type A · Réflexe SSP · v1

LOT_003 audité · Phase A + Phase B (DX.1–13) · 85 questions Type A, 5 options · examen fédéral CH (CK) · 49 EX · 23 AP · 13 SPE

🧭 Carte mentale G3 · 60 secondes avant de répondre

EX Examen — vignette type examen fédéral CK : décision clinique, 5 options. Priorité absolue.

AP Approfondissement — mécanismes, nuances, raisonnement enrichi. Texte en bleu.

SPE · spécialité Spécialiste — niveau spécialité. Touchez 🔥 quand une question vous passionne : le score dira quelle spécialité vous exalte.

Version papier : répondez d'abord ; le corrigé commenté est en annexe, après la dernière question. Version écran : choisissez une option → elle se marque **juste** ou **fausse**. Le commentaire ne s'ouvre **que** si vous touchez 💡.

Les 3 questions réflexes devant toute soif excessive

1. **Danger maintenant ?** Confusion, convulsion, vomissements, Kussmaul, hypotension → **glycémie capillaire, cétones, natrémie, gaz du sang**.
2. **Vraie polyurie ?** Diurèse de 24 h > 3 L (> 40–50 mL/kg). Sans polyurie : bouche sèche (Sjögren, anticholinergiques).
3. **Soluté ou eau ?** Glycémie, calcémie, créatinine ; puis osmolalité urinaire < 300 → **copeptine**.

🍬 Glucose

- Aléatoire ≥ 11,1 + symptômes → diabète (DX.1), sans 2e test
- BHB ≥ 3,0 + pH < 7,30 → acidocétose (DX.9) ; ≈ 10 % euglycémiques
- Glycémie très haute, osmolalité ≥ 320, BHB < 3,0 → SHH (DX.10)

💧 Axe AVP

- Copeptine basale ≥ 21,4 → néphrogénique (DX.4, DX.7)
- Stimulée NaCl 3 % > 4,9 (arginine > 3,8) → polydipsie primaire (DX.2)
- ≤ 4,9 → central (DX.4, DX.11) : IRM
- Na ≥ 150 + urine diluée → diabète insipide sans test

🦴 Calcium · rein

- Ca corrigé haut + PTH haute ×2 → hyperparathyroïdie (DX.5)
- Ca corrigé > 3,0 + PTH basse + cancer → maligne (DX.13)
- DFGe < 60 ou RAC ≥ 3 > 3 mois → IRC (DX.3)

🏜️ Pertes · sécheresse

- Chaleur, fièvre, diarrhée, osmolalité ≥ 295 → déshydratation (DX.8)
- Na > 145, hypotension → E3 (DX.12) : isotonique d'abord
- Bouche et yeux secs sans polyurie, anti-SSA → Sjögren (DX.6)
- Lithium, diurétique, anticholinergique → DX.7

🚩 Ordre d'exclusion

1. 0 · **Hyponatrémie symptomatique** (grand buveur confus ou convulsif)
2. E1 Acidocétose (DX.9)
3. E2 SHH (DX.10)
4. E3 Hypernatrémie, choc hypovolémique (DX.12)
5. E4 Hypercalcémie maligne (DX.13)
6. E5 Lésion hypothalamo-hypophysaire (DX.11)
7. Puis : hyperparathyroïdie, diabète, IRC, médicaments, diabète insipide, polydipsie primaire, Sjögren, déshydratation

Jamais de desmopressine « pour tester » : hyponatrémie en polydipsie primaire.

① Raisonner · 15 Q · avant de nommer le diagnostic

Assoiffé et confus ? Glycémie, cétones, natrémie d'abord. Stable ? Prouver la polyurie, écarter un soluté, puis l'osmolalité urinaire.

Q1 **EX** **DX.9 🚩E1 vs DX.12 · DX.2** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 45 ans est amené aux urgences par son épouse : depuis 4 jours, il boit « sans arrêt » ; ce matin, il est somnolent et désorienté. PA 104/62 mmHg, FC 112/min, FR 28/min. Aucun antécédent connu ; ses médicaments ne sont pas connus.

Quel examen faut-il obtenir en premier ?

- **A** IRM cérébrale
- **B** Glycémie, cétones et natrémie
- **C** Copeptine basale
- **D** Calcémie corrigée par l'albumine et PTH intacte
- **E** Test de restriction hydrique

Q2 **EX** **DX.1 · symptômes classiques** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 52 ans consulte pour une soif intense et des mictions fréquentes depuis 6 semaines ; il a perdu 4 kg sans régime. Glycémie veineuse aléatoire 14,2 mmol/L. Pas de vomissements, état général conservé.

Quelle est la conclusion la plus appropriée ?

- **A** Un second dosage à jeun est nécessaire avant de conclure
- **B** Une HGPO de 75 g doit confirmer le diagnostic
- **C** Le diabète est établi sans second test
- **D** Il s'agit d'un prédiabète à recontrôler
- **E** Une glycosurie doit d'abord être documentée

Q3 **EX** **DX.4 vs DX.2 · prouver la polyurie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 38 ans dit uriner « des litres » et boire 4 à 5 L par jour depuis 2 mois. Glycémie, HbA1c, créatinine et calcémie sont normales. Elle va bien par ailleurs.

Quel examen faut-il demander d'abord ?

- **A** IRM hypophysaire
- **B** Copeptine stimulée par perfusion de NaCl 3 %
- **C** Diurèse de 24 h et osmolalité urinaire
- **D** Essai de desmopressine
- **E** Test de privation hydrique

Q4 **EX** **DX.2 vs DX.4 · anamnèse** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 30 ans boit environ 5 L par jour depuis plus d'un an ; le début a été insidieux. Il dort toute la nuit sans se lever pour boire ni uriner. Il est suivi pour un trouble anxieux. Glycémie, calcémie et créatinine normales ; natrémie 136 mmol/L.

Quel diagnostic est le plus probable à ce stade ?

- **A** Diabète insipide central
- **B** Diabète insipide néphrogénique
- **C** Diabète sucré
- **D** Polydipsie primaire
- **E** Insuffisance rénale chronique

Q5 **EX** **DX.3 · chronicité** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 68 ans, hypertendue, a un DFGe à 55 mL/min/1,73 m² sur un bilan de routine ; c'est le premier dosage. Elle signale une nycturie. Aucune autre anomalie connue.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Retenir d'emblée une IRC de stade G3a
- **B** Adresser d'emblée en néphrologie
- **C** Répéter DFGe et RAC à 3 mois
- **D** Débuter un inhibiteur du SGLT2 sans autre bilan
- **E** Demander une biopsie rénale

Q6 **EX** **DX.11 🚩E5 vs DX.2** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 41 ans a une polyurie de 6 L par jour apparue brutalement il y a 3 semaines. Elle a des céphalées et se cogne aux encadrements de porte ; vous notez une réduction du champ visuel. Glycémie et calcémie normales.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Essai de desmopressine à domicile
- **B** Test de privation hydrique ambulatoire
- **C** Carnet mictionnel de 3 jours et contrôle clinique dans 3 mois
- **D** Échographie rénale
- **E** IRM hypophysaire urgente et bilan hypophysaire

Q7 **EX** **DX.12 🚩E3 vs DX.8** Prise en charge · urgences

Un homme de 78 ans est retrouvé au sol chez lui après 2 jours sans boire. PA 78/45 mmHg, FC 124/min, extrémités froides, oligurie. Natrémie 162 mmol/L.

Quelle est la première mesure thérapeutique ?

- **A** Cristalloïde isotonique en bolus
- **B** Glucose 5 % rapide pour abaisser la natrémie
- **C** Noradrénaline seule
- **D** Eau par sonde gastrique
- **E** NaCl 0,45 % en perfusion lente

Q8 EX DX.13 🚩E4 vs DX.5 Prise en charge · hôpital

Une femme de 67 ans traitée pour un cancer bronchique est confuse, constipée et très assoiffée. Calcémie corrigée 3,4 mmol/L ; PTH basse ; créatinine légèrement élevée. Pas d'insuffisance cardiaque.

Quelle est la première mesure thérapeutique ?

A Zolédronate 4 mg IV immédiat, avant toute perfusion de sérum

B Calcitonine seule

C Réhydratation par NaCl 0,9 %, puis antirésorptif IV

D Prednisone 60 mg/j

E Parathyroïdectomie

Q9 EX DX.10 🚩E2 vs DX.9 Évaluation / diagnostic · EMS

Une résidente d'EMS de 84 ans, diabétique de type 2, est de plus en plus confuse depuis 4 jours et boit peu. Glycémie 41 mmol/L, osmolalité 342 mOsm/kg, β-hydroxybutyrate 0,8 mmol/L, pH 7,37, bicarbonate 23 mmol/L. Muqueuses sèches, PA 98/60 mmHg.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

A Syndrome hyperosmolaire hyperglycémique

B Acidocétose diabétique

C État mixte acidocétose et hyperosmolarité

D Diabète insipide avec hypernatrémie

E Démence évolutive avec déshydratation simple

Q10 **EX** **DX.9 🚩E1 · ordre** Prise en charge · urgences

Une femme de 19 ans, diabétique de type 1, arrive aux urgences : vomissements depuis 12 heures, respiration ample et profonde, haleine fruitée. Glycémie 24 mmol/L, β-hydroxybutyrate 5,1 mmol/L, pH 7,14, bicarbonate 12 mmol/L. La kaliémie est en cours d'analyse.

Quelle est la première mesure thérapeutique ?

- **A** Insuline IV 0,1 UI/kg/h immédiatement
- **B** Bicarbonate de sodium IV
- **C** Glucose 5 % IV
- **D** Insuline sous-cutanée et retour à domicile
- **E** NaCl 0,9 % 500 à 1000 mL/h

Q11 **EX** **DX.5 vs DX.13 · confirmer** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 58 ans consulte pour une soif et une polyurie modérées ; elle a eu une colique néphrétique l'an dernier. Calcémie corrigée 2,78 mmol/L ; PTH élevée. Pas de cancer connu, pas de thiazidique ni de lithium.

Quelle est l'étape suivante avant de retenir le diagnostic ?

- **A** Échographie cervicale de localisation des parathyroïdes
- **B** Recontrôler calcémie et PTH à ≥ 2 semaines
- **C** Dosage de la PTHrP
- **D** Parathyroïdectomie d'emblée
- **E** Zolédronate 4 mg IV

Q12 **EX** **DX.6 vs DX.4 · soif sans polyurie** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 55 ans dit avoir « tout le temps soif » : elle doit boire pour avaler le pain. Ses yeux brûlent « comme du sable ». Diurèse de 24 h : 1,6 L. Glycémie et calcémie normales.

Quelle démarche est la plus appropriée ?

- **A** Copeptine basale
- **B** Revoir les médicaments, puis anti-SSA et tests de sécheresse
- **C** Test de restriction hydrique pour exclure un diabète insipide
- **D** IRM hypophysaire
- **E** Essai de desmopressine

Q13 **EX** **DX.7 vs DX.4 · lithium** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 44 ans, traité par lithium depuis 6 ans pour un trouble bipolaire, urine 5 L par jour et se lève deux fois la nuit pour boire. Il est bien orienté ; pas de tremblement. Glycémie normale.

Quel examen faut-il demander en premier ?

- **A** Lithiémie, avec natrémie, calcémie et créatinine
- **B** IRM hypophysaire
- **C** Test de restriction hydrique ambulatoire sur 24 heures
- **D** Copeptine stimulée par NaCl 3 %
- **E** Essai de desmopressine

Q14 **EX** **DX.8 · coup de chaleur** Prise en charge · urgences

Un ouvrier de 32 ans s'effondre sur un chantier en pleine canicule. Température centrale 40,8 °C ; il est confus et agité ; peau chaude ; FC 128/min ; PA 102/64 mmHg.

Quelle est la mesure prioritaire ?

- **A** Réhydratation orale et repos à l'ombre
- **B** Attendre la natrémie avant tout geste
- **C** Glucose 5 % rapide en premier
- **D** Refroidissement immédiat par immersion dans l'eau
- **E** Restriction hydrique

Q15 **EX** **DX.4 néphrogénique vs DX.2** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 47 ans a une polyurie de 5 L/24 h, une osmolalité urinaire de 180 mOsm/kg, une glycémie et une calcémie normales. La copeptine basale, prélevée sans restriction hydrique, est de 26 pmol/L.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Test de stimulation par NaCl 3 % pour confirmer le type
- **B** Chercher lithium, hypercalcémie, hypokaliémie
- **C** Test à l'arginine
- **D** IRM hypophysaire
- **E** Desmopressine sublinguale

② Discriminer · 59 Q · un signe, un examen qui tranche

Les 13 DX du LOT face à face : un signe, un examen qui tranche, une conduite. Les questions AP (bleu) et SPE (violet) sont mêlées aux EX : filtrez par niveau en haut.

Q16 **EX** **DX.1 · prédiabète** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 49 ans, en surpoids, sans symptôme, a une HbA1c à 6,0 % sur un bilan de routine. Glycémie à jeun 6,2 mmol/L.

Comment interpréter ce bilan ?

- **A** Prédiabète
- **B** Diabète de type 2 confirmé
- **C** Diabète à confirmer par une HGPO immédiate
- **D** Bilan normal
- **E** Diabète insipide débutant

Q17 **EX** **DX.1 vs DX.3 · metformine** Prise en charge · cabinet

Une femme de 63 ans a un diabète de type 2 nouvellement diagnostiqué (HbA1c 7,4 %). Son DFGe est stable à 26 mL/min/1,73 m² depuis un an.

Quelle affirmation est correcte concernant la metformine ?

- **A** Elle se débute à 500 mg par jour
- **B** Elle est autorisée jusqu'à 1000 mg par jour
- **C** Elle se donne à pleine dose, 3000 mg/j
- **D** Elle remplace l'insuline à jeun
- **E** Elle est contre-indiquée chez cette patiente

Q18 **SPE · Endocrinologie** **DX.1 · DFGe 30–59** Prise en charge · cabinet

Un homme de 71 ans, diabétique de type 2, a un DFGe stable à 42 mL/min/1,73 m². Son médecin veut augmenter la metformine (actuellement 500 mg 2 fois par jour).

Quelle dose quotidienne maximale l'AIPS autorise-t-elle ?

- **A** 500 mg
- **B** 2000 mg
- **C** 3000 mg
- **D** 1000 mg
- **E** Arrêt obligatoire

Q19 **AP** **DX.1 vs DX.9 · iSGLT2** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 57 ans, diabétique de type 2 sous empagliflozine (Jardiance®), vomit depuis la veille et se sent très faible. Glycémie capillaire 12 mmol/L.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Rassurer : une glycémie à 12 mmol/L exclut l'acidocétose
- **B** Doubler l'empagliflozine
- **C** Bandelette urinaire seule
- **D** Antiémétique et retour à domicile
- **E** Doser les cétones (β-hydroxybutyrate) et le pH

Q20 **EX** **DX.2 vs DX.4 · copeptine stimulée** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 34 ans a une polyurie hypotonique (6 L/24 h, osmolalité urinaire 120 mOsm/kg). Glycémie, calcémie et créatinine normales. Copeptine basale 3,1 pmol/L. Sous NaCl 3 %, la natrémie atteint 151 mmol/L ; la copeptine stimulée est de 9,8 pmol/L.

Quel est le diagnostic ?

- **A** Polydipsie primaire
- **B** Diabète insipide central
- **C** Diabète insipide néphrogénique
- **D** Zone limite : répéter le test
- **E** Insuffisance rénale chronique

Q21 **EX** **DX.2 · desmopressine** Prise en charge · cabinet

Une femme de 29 ans boit 6 L par jour ; une polydipsie primaire est confirmée par la copeptine stimulée. Elle demande « un médicament pour uriner moins ».

Quelle attitude est correcte ?

- **A** Desmopressine sublinguale 60 µg 3 fois par jour
- **B** Refuser la desmopressine : elle est contre-indiquée
- **C** Hydrochlorothiazide 100 mg par jour
- **D** Restriction hydrique stricte immédiate à 1 L
- **E** Essai de desmopressine pour confirmer

Q22 **AP** **DX.2 · faibles solutés** Mécanismes · cabinet

Un homme de 52 ans boit chaque jour 5 à 6 L de bière et mange très peu. Il est amené pour confusion ; natrémie 118 mmol/L.

Quel mécanisme explique le mieux son hyponatrémie ?

- **A** La bière stimule directement la sécrétion d'AVP
- **B** L'alcool provoque un diabète insipide néphrogénique
- **C** Le rein normal ne peut pas excréter plus de 2 L d'eau par jour, quel que soit l'apport
- **D** La perte digestive de sodium domine
- **E** L'apport faible de solutés réduit l'excrétion d'eau à environ 4 L/jour

Q23 **SPE · Psychiatrie** **DX.2 · correction prudente** Prise en charge · hôpital

Un homme de 41 ans, schizophrène, alcoolodépendant et dénutri, est hospitalisé pour une hyponatrémie à 116 mmol/L après une polydipsie massive. Il a eu une crise convulsive ; on débute du NaCl 3 %.

Quelle hausse maximale de la natrémie sur 24 heures faut-il viser ?

- **A** 10 mmol/L
- **B** 12 mmol/L
- **C** 15 mmol/L
- **D** 8 mmol/L
- **E** Aucune limite tant que la convulsion persiste

Q24 **EX** **DX.3 · hyperkaliémie** Prise en charge · urgences

Une femme de 74 ans en IRC stade G4 est adressée pour une faiblesse. Kaliémie 7,1 mmol/L ; l'ECG montre des ondes T pointues et un élargissement du QRS.

Quelle est la première mesure ?

- **A** Furosémide IV
- **B** Résine échangeuse orale seule
- **C** Contrôle de la kaliémie dans 2 heures
- **D** Gluconate de calcium IV
- **E** Bicarbonate de sodium oral

Q25 **EX** **DX.3 · polyurie de l'IRC** Mécanismes · cabinet

Un homme de 66 ans en IRC stade G3b (DFGe 38) se plaint d'une nycturie et d'une soif modérée. Glycémie et calcémie normales.

Quel mécanisme explique sa polyurie ?

- **A** Diurèse osmotique par le glucose
- **B** Défaut de sécrétion d'AVP
- **C** Perte de la capacité tubulaire de concentrer l'urine
- **D** Prise d'eau excessive primaire
- **E** Hypercalcémie

Q26 **AP** **DX.3 · stade KDIGO** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 60 ans a, depuis 8 mois, un DFGe entre 48 et 52 mL/min/1,73 m² et une RAC entre 5 et 8 mg/mmol à chaque contrôle.

Quelle classification KDIGO s'applique ?

- **A** G2 A1
- **B** G3b A2
- **C** G3a A2
- **D** G3a A3
- **E** Pas d'IRC : durée insuffisante

Q27 **AP** **DX.3 · iSGLT2** Prise en charge · cabinet

Une femme de 70 ans a une IRC avec albuminurie ; DFGe 22 mL/min/1,73 m². Son néphrologue envisage un iSGLT2.

Selon l'AIPS, quelle affirmation est correcte ?

- **A** Aucun iSGLT2 ne s'instaure sous 45
- **B** L'empagliflozine ne s'instaure pas sous 30
- **C** La dapagliflozine s'instaure dès 15
- **D** La dapagliflozine ne s'instaure pas sous 25 mL/min/1,73 m²
- **E** Les iSGLT2 sont réservés au diabète

Q28 **SPE · Néphrologie** **DX.3 · anémie rénale** Prise en charge · hôpital

Un homme de 68 ans en IRC non dialysée reçoit de la darbépoétine alfa (Aranesp®) pour une anémie. Son hémoglobine est passée de 98 à 121 g/L.

Quelle limite d'hémoglobine l'AIPS fixe-t-elle ?

- **A** 120 g/L au plus
- **B** 100 g/L au plus
- **C** 130 g/L au plus
- **D** 140 g/L au plus
- **E** Aucune limite si bien toléré

Q29 **EX** **DX.4 vs DX.2 · natrémie** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 36 ans a une polyurie de 7 L/24 h. Osmolalité urinaire 110 mOsm/kg ; natrémie 152 mmol/L ; glycémie et calcémie normales.

Quelle conclusion est la plus appropriée ?

- **A** Diabète insipide, sans test supplémentaire
- **B** Polydipsie primaire probable
- **C** Test de stimulation par NaCl 3 % indispensable
- **D** Test de restriction hydrique
- **E** Diurèse osmotique

Q30 **EX** **DX.4 néphrogénique · traitement** Prise en charge · cabinet

Un homme de 50 ans a un diabète insipide néphrogénique sur hypokaliémie ancienne ; la kaliémie est corrigée mais la polyurie persiste. Pas de lithium.

Quel traitement est indiqué ?

- **A** Desmopressine sublinguale
- **B** Restriction hydrique stricte
- **C** Hydrochlorothiazide
- **D** Furosémide
- **E** Pilocarpine

Q31 **AP** **DX.4 · privation hydrique** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un interne propose un test de privation hydrique pour distinguer diabète insipide central et polydipsie primaire chez une patiente stable à natrémie normale.

Quelle affirmation sur ce test est correcte ?

- **A** C'est l'étalon actuel, plus précis que la copeptine
- **B** Sa précision globale dépasse 95 %
- **C** Il est validé de façon prospective
- **D** Il est sans danger dans le diabète insipide
- **E** Sa précision n'est que de 41 % pour la polydipsie primaire

Q32 **AP** **DX.4 · enfant** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un garçon de 8 ans a une polyurie hypotonique ; glycémie, calcémie et créatinine normales ; copeptine basale 2,4 pmol/L.

Quel test de stimulation faut-il préférer ?

- **A** Test à l'arginine
- **B** Test au NaCl 3 %
- **C** Test de privation hydrique
- **D** Essai de desmopressine
- **E** Aucun : la basale suffit

Q33 **AP** **DX.4 · desmopressine du sujet âgé** Prise en charge · cabinet

Une femme de 72 ans débute de la desmopressine pour un diabète insipide central confirmé.

Quand faut-il contrôler la natrémie ?

- **A** Seulement à 3 mois
- **B** Aucun contrôle si la diurèse baisse
- **C** Avant le début et 3 jours après
- **D** Une fois par an
- **E** Seulement en cas de convulsion

Q34 **SPE · Endocrinologie pédiatrique** **DX.4 vs DX.11 · étiologie** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un garçon de 12 ans a un diabète insipide central isolé, sans céphalée ni trouble visuel. L'IRM est prévue.

Quelles étiologies faut-il évoquer en priorité ?

- **A** Adénome hypophysaire
- **B** Hyperparathyroïdie primaire
- **C** Craniopharyngiome ou germinome
- **D** Prise de lithium
- **E** Polydipsie primaire

Q35 **EX** **DX.5 · critère chirurgical** Prise en charge · cabinet

Une femme de 46 ans, asymptomatique, a une hyperparathyroïdie primaire confirmée : calcémie corrigée 2,70 mmol/L (norme supérieure 2,55), DFGe 85, T-score −1,8, pas de calcul.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Surveillance annuelle : aucun critère chirurgical n'est rempli
- **B** Cinacalcet au long cours
- **C** Restriction du calcium alimentaire
- **D** Zolédronate IV
- **E** Parathyroïdectomie, car elle a moins de 50 ans

Q36 **AP** **DX.5 vs HHF · clairance** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 40 ans a une calcémie corrigée à 2,68 mmol/L et une PTH normale-haute. Le rapport de clairance calcium/créatinine est de 0,006.

Quel diagnostic faut-il évoquer avant toute chirurgie ?

- **A** Hypercalcémie hypocalciurique familiale
- **B** Hyperparathyroïdie primaire typique
- **C** Hypercalcémie maligne
- **D** Intoxication à la vitamine D
- **E** Syndrome de Sjögren

Q37 **SPE · Endocrinologie** **DX.5 · cinacalcet** Prise en charge · hôpital

Un homme de 82 ans, inopérable, a une hyperparathyroïdie primaire symptomatique ; on débute Cinacalcet-Mepha.

Quel schéma correspond à l'AIPS ?

- **A** 90 mg 4 fois par jour d'emblée
- **B** 30 mg 2 fois par jour ; calcémie à 1 semaine
- **C** 30 mg 1 fois par semaine
- **D** 60 mg par jour sans contrôle
- **E** 30 mg 2 fois par jour ; calcémie à 6 mois

Q38 **EX** **DX.6 · score ACR/EULAR** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 52 ans a une sécheresse buccale et oculaire depuis 2 ans. Anti-SSA positifs ; test de Schirmer 4 mm en 5 minutes. Pas de biopsie. Aucun critère d'exclusion.

Quel est le score ACR/EULAR 2016 et la conclusion ?

- **A** 3 points : non classé
- **B** 6 points : classé
- **C** 2 points : non classé
- **D** Biopsie indispensable pour conclure
- **E** 4 points : syndrome de Sjögren classé

Q39 **EX** **DX.6 · pilocarpine** Prise en charge · cabinet

Une femme de 60 ans a un syndrome de Sjögren primaire avec xérostomie gênante ; il reste des glandes fonctionnelles.

Quelle posologie de pilocarpine (Salagen®) l'AIPS indique-t-elle ?

- **A** 5 mg 4 fois par jour, pendant les repas
- **B** 5 mg 1 fois par jour
- **C** 30 mg 1 fois par jour
- **D** 10 mg 4 fois par jour
- **E** 5 mg 3 fois par jour

Q40 **AP** **DX.6 · anti-SSA seul** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 45 ans a une bouche sèche et des anti-SSA positifs. Schirmer 12 mm, débit salivaire 0,3 mL/min, coloration oculaire normale, pas de biopsie.

Quelle conclusion est correcte ?

- **A** Score de 4 : Sjögren classé
- **B** Les anticorps antinucléaires suffiraient à conclure
- **C** Score de 3 : critères non atteints
- **D** Sjögren exclu définitivement
- **E** Diabète insipide associé

Q41 **AP** **DX.6 · lymphome** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 63 ans, suivie pour un syndrome de Sjögren, signale depuis 2 mois une tuméfaction parotidienne dure et persistante ; vous palpez des adénopathies.

Quel diagnostic faut-il rechercher ?

- **A** Lymphome
- **B** Poussée de sécheresse simple
- **C** Diabète insipide
- **D** Hyperparathyroïdie
- **E** Effet indésirable de la pilocarpine

Q42 **EX** **DX.7 · lithiémie** Prise en charge · cabinet

Une femme de 39 ans débute du lithium (Lithiofor®) pour un trouble bipolaire. Elle demande quand faire la prise de sang de contrôle.

Quelle cible et quel moment de prélèvement sont corrects ?

- **A** 0,6 à 1,0 mmol/L, 2 heures après la prise
- **B** 1,5 à 2,0 mmol/L, à jeun
- **C** 0,2 à 0,4 mmol/L, au coucher
- **D** 0,6 à 1,0 mmol/L, 12 heures après la dernière prise
- **E** Aucune lithiémie si pas de symptôme

Q43 **EX** **DX.7 vs DX.4 · desmopressine** Prise en charge · cabinet

Un homme de 55 ans a un diabète insipide néphrogénique dû au lithium, prouvé par une copeptine basale élevée. Un collègue propose de la desmopressine.

Quelle réponse est correcte ?

- **A** Inefficace : le rein ne répond plus à l'ADH
- **B** Indiquée à 60 µg 3 fois par jour
- **C** Indiquée si la natrémie est basse
- **D** Plus efficace que le thiazide
- **E** Indiquée, à associer à une restriction hydrique stricte

Q44 **SPE · Psychiatrie** **DX.7 · interactions** Prise en charge · cabinet

Un homme de 62 ans sous lithium, lithiémie stable à 0,8 mmol/L, se voit prescrire de l'ibuprofène pour une lombalgie et du lisinopril pour une hypertension.

Quel est le risque principal ?

- **A** Baisse de la lithiémie
- **B** Diabète insipide central
- **C** Hausse de la lithiémie
- **D** Hypercalcémie maligne
- **E** Aucun : ces associations sont neutres

Q45 **SPE · Néphrologie** **DX.7 · dialyse** Prise en charge · hôpital

Une femme de 70 ans sous lithium est hospitalisée pour confusion après une gastro-entérite. Lithiémie 4,4 mEq/L ; créatinine nettement élevée.

Quelle mesure faut-il envisager ?

- **A** Réduction de moitié de la dose de lithium
- **B** Hydrochlorothiazide
- **C** Dialyse
- **D** Desmopressine
- **E** Contrôle de la lithiémie dans une semaine

Q46 **AP** **DX.7 · anticholinergique** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 76 ans se plaint d'une bouche sèche et boit beaucoup depuis l'introduction d'un médicament anticholinergique pour une vessie hyperactive. Diurèse 1,5 L/24 h ; natrémie 139 mmol/L.

Quelle est l'explication la plus probable ?

- **A** Diabète insipide néphrogénique
- **B** Bouche sèche médicamenteuse
- **C** Polydipsie primaire
- **D** Syndrome hyperosmolaire
- **E** Hypernatrémie

Q47 **EX** **DX.8 · enfant déshydraté** Prise en charge · cabinet

Un garçon de 3 ans, 14 kg, a une gastro-entérite depuis 2 jours ; il a perdu 7 % de son poids. Il boit, n'a pas de sang dans les selles et reste réactif.

Quelle réhydratation est appropriée ?

- **A** Solution orale, 50 mL/kg en 6 heures
- **B** Perfusion de NaCl 0,9 % en bolus
- **C** Eau plate à volonté
- **D** Lopéramide
- **E** Solution orale hypoosmolaire, 100 mL/kg en 6 heures

Q48 **AP** **DX.8 · définition** Évaluation / diagnostic · EMS

Une résidente d'EMS de 88 ans a la bouche sèche et dit avoir soif. Natrémie 146 mmol/L ; urée élevée ; osmolalité sérique 302 mOsm/kg.

Quelle conclusion est la plus appropriée ?

- **A** Déshydratation exclue : la soif suffit à l'écarter
- **B** Déshydratation imminente seulement
- **C** Polydipsie primaire
- **D** Déshydratation par perte d'eau établie
- **E** Syndrome de Sjögren

Q49 **AP** **DX.8 · signe isolé** Évaluation / diagnostic · EMS

Une infirmière d'EMS demande si une bouche sèche suffit à affirmer la déshydratation d'un résident de 85 ans.

Quelle réponse est correcte ?

- **A** Non, aucun signe clinique isolé n'est fiable
- **B** Oui, la bouche sèche est un signe spécifique chez le sujet âgé
- **C** Oui, si la soif est présente
- **D** Oui, si les urines sont foncées
- **E** Non, seule l'IRM tranche

Q50 **EX** **DX.9 · potassium** Prise en charge · urgences

Une femme de 24 ans, diabétique de type 1, est en acidocétose (pH 7,12, β-hydroxybutyrate 4,8 mmol/L). Elle reçoit du NaCl 0,9 % depuis 30 minutes. Kaliémie 3,0 mmol/L.

Quelle est la conduite correcte ?

- **A** Insuline 0,1 UI/kg/h immédiatement
- **B** Potassium 10 mmol/h ; retarder l'insuline jusqu'à K > 3,5
- **C** Bicarbonate de sodium IV
- **D** Arrêter la perfusion
- **E** Insuline et potassium simultanés à pleine dose

Q51 **EX** **DX.9 · glucose** Prise en charge · urgences

Un homme de 30 ans en acidocétose reçoit de l'insuline IV à 0,1 UI/kg/h. Après 5 heures, glycémie 12,8 mmol/L ; pH 7,24 ; β-hydroxybutyrate 2,1 mmol/L.

Quelle est la prochaine étape ?

- **A** Arrêter l'insuline : la glycémie est presque normale
- **B** Relais sous-cutané immédiat
- **C** Augmenter l'insuline à 0,2 UI/kg/h
- **D** Ajouter glucose 5–10 % et réduire l'insuline à 0,05 UI/kg/h
- **E** Bicarbonate IV

Q52 **EX** **DX.9 · résolution** Prise en charge · hôpital

Une femme de 22 ans traitée pour acidocétose a, au matin : β-hydroxybutyrate 0,4 mmol/L, pH 7,33, bicarbonate 19 mmol/L. Elle mange.

Quelle est l'étape suivante ?

- **A** Poursuivre l'insuline IV 24 heures
- **B** Arrêter l'insuline IV puis attendre la glycémie du lendemain avant tout relais
- **C** Contrôler la cétonurie avant de décider
- **D** Relais sous-cutané avec chevauchement de 1 à 2 heures
- **E** Attendre la normalisation du trou anionique

Q53 **SPE · Pédiatrie** **DX.9 · œdème cérébral de l'enfant** Prise en charge · hôpital

Un garçon de 9 ans traité pour acidocétose devient, à la 6e heure, céphalalgique, bradycarde et somnolent.

Quelle est la conduite immédiate ?

- **A** Scanner cérébral d'abord
- **B** Augmenter le débit de perfusion
- **C** Mannitol IV 0,5 à 1 g/kg
- **D** Bicarbonate IV
- **E** Insuline en bolus

Q54 **EX** **DX.10 · insuline** Prise en charge · urgences

Un homme de 79 ans a un syndrome hyperosmolaire pur (glycémie 45 mmol/L, osmolalité 350 mOsm/kg, β-hydroxybutyrate 0,5 mmol/L, pH 7,38). Il reçoit du NaCl 0,9 % ; la glycémie baisse régulièrement.

Quand faut-il débuter l'insuline ?

- **A** Immédiatement à 0,1 UI/kg/h
- **B** Immédiatement en bolus de 10 UI
- **C** Jamais
- **D** Après normalisation de l'osmolalité
- **E** Quand la glycémie cesse de baisser sous perfusion

Q55 **EX** **DX.10 vs DX.9 · état mixte** Prise en charge · urgences

Une femme de 68 ans, diabétique de type 2, est confuse et hypovolémique. Glycémie 38 mmol/L, osmolalité 334 mOsm/kg, β-hydroxybutyrate 4,2 mmol/L, pH 7,18, bicarbonate 12 mmol/L.

Quel protocole d'insuline appliquer ?

- **A** SHH pur : insuline retardée
- **B** Insuline 0,05 UI/kg/h d'emblée
- **C** Insuline sous-cutanée basale
- **D** Protocole de l'acidocétose, 0,1 UI/kg/h
- **E** Pas d'insuline avant 24 h

Q56 **AP** **DX.10 · vitesse** Prise en charge · hôpital

Chez un homme de 81 ans traité pour SHH, l'osmolalité passe de 352 à 330 mOsm/kg en 2 heures.

Comment interpréter cette évolution ?

- **A** Idéale : plus vite, c'est mieux
- **B** Trop rapide : la cible est 3 à 8 mOsm/kg par heure
- **C** Trop lente
- **D** Sans importance si la glycémie baisse
- **E** Signe de guérison

Q57 **AP** **DX.10 · natrémie qui monte** Prise en charge · hôpital

Chez une femme de 77 ans traitée pour SHH par NaCl 0,9 %, la natrémie monte de 134 à 140 mmol/L tandis que la glycémie baisse ; l'osmolalité diminue de 4 mOsm/kg/h.

Quelle est la conduite appropriée ?

- **A** Passer immédiatement au NaCl 0,45 %
- **B** Arrêter toute perfusion
- **C** Glucose 5 % en remplacement
- **D** Desmopressine
- **E** Poursuivre le NaCl 0,9 %

Q58 **SPE · Médecine intensive** **DX.10 · thromboprophylaxie** Prise en charge · hôpital

Un homme de 83 ans hospitalisé pour SHH a une clairance de la créatinine à 25 mL/min.

Quelle prophylaxie antithrombotique l'AIPS prévoit-elle ?

- **A** Énoxaparine 40 mg par jour
- **B** Énoxaparine 20 mg par jour
- **C** Aucune prophylaxie
- **D** Énoxaparine 1 mg/kg 2 fois par jour
- **E** Aspirine 100 mg

Q59 **EX** **DX.11 · ordre de substitution** Prise en charge · hôpital

Une femme de 45 ans a un diabète insipide central après la découverte d'une masse sellaire ; le bilan montre aussi une insuffisance corticotrope et thyréotrope.

Quel ordre de substitution faut-il suivre ?

- **A** Lévothyroxine avant glucocorticoïde
- **B** Desmopressine seule, sans autre hormone
- **C** Lévothyroxine et glucocorticoïde le même jour, à doses pleines
- **D** Glucocorticoïde avant lévothyroxine
- **E** Aucune substitution avant la chirurgie

Q60 **EX** **DX.11 · après chirurgie hypophysaire** Prise en charge · hôpital

Un homme de 52 ans a été opéré d'une lésion hypophysaire il y a 2 jours. Il urine abondamment et a soif.

Quelle surveillance s'impose ?

- **A** Natrémie à 1 mois seulement
- **B** Restriction hydrique stricte
- **C** Natrémie et diurèse au moins quotidiennes
- **D** IRM quotidienne
- **E** Lithiémie

Q61 **AP** **DX.11 vs DX.2 · natrémie de base** Évaluation / diagnostic · hôpital

Deux patients ont une polyurie hypotonique avec glycémie et calcémie normales. Le premier a une natrémie de base à 147 mmol/L ; le second à 133 mmol/L.

Quelle orientation est correcte ?

- **A** Premier : polydipsie primaire ; second : déficit en AVP
- **B** Les deux : polydipsie primaire
- **C** Les deux : déficit en AVP
- **D** Premier : déficit en AVP ; second : polydipsie primaire
- **E** La natrémie n'oriente pas

Q62 **SPE · Endocrinologie** **DX.11 · cortisol et polyurie** Mécanismes · hôpital

Une femme de 39 ans, avec masse hypothalamique, reçoit de l'hydrocortisone pour une insuffisance corticotrope. Deux jours plus tard, sa polyurie passe de 3 à 7 L.

Quelle explication est la plus probable ?

- **A** Surdosage en hydrocortisone provoquant un diabète sucré
- **B** Polydipsie primaire déclenchée par le traitement
- **C** Diabète insipide néphrogénique iatrogène
- **D** Le cortisol démasque un déficit en AVP
- **E** Hypercalcémie

Q63 **AP** **DX.11 · desmopressine et vomissements** Prise en charge · cabinet

Un homme de 48 ans sous desmopressine pour un déficit en AVP a une gastro-entérite fébrile avec vomissements.

Quelle conduite est appropriée ?

- **A** Doubler la desmopressine
- **B** Restriction hydrique stricte
- **C** Passer à l'hydrochlorothiazide
- **D** Poursuivre sans changement
- **E** Suspendre la desmopressine

Q64 **EX** **DX.12 · déficit en eau** Prise en charge · hôpital

Un homme de 78 ans, 70 kg, a une hypernatrémie à 154 mmol/L, sans choc.

Quel est son déficit en eau estimé ?

- **A** Environ 3,5 L
- **B** Environ 4,2 L
- **C** Environ 1,5 L
- **D** Environ 7 L
- **E** Impossible à estimer

Q65 **EX** **DX.12 · vitesse de correction** Prise en charge · hôpital

Un homme de 84 ans a une hypernatrémie à 158 mmol/L de durée inconnue ; il est hémodynamiquement stable.

Quelle vitesse de baisse de la natrémie viser ?

- **A** 1 à 2 mmol/L/h pendant 24 h
- **B** Normalisation en 6 heures
- **C** Moins de 0,5 mmol/L/h, soit 12 mmol/L par jour
- **D** Moins de 0,1 mmol/L/h
- **E** Aucune limite

Q66 **EX** **DX.12 · noradrénaline** Prise en charge · urgences

Une femme de 75 ans est en choc hypovolémique après une diarrhée profuse ; PA 70/40 mmHg ; natrémie 153 mmol/L. L'interne propose de débuter la noradrénaline.

Quelle réponse est correcte ?

- **A** Noradrénaline seule, sans remplissage préalable, pour gagner du temps
- **B** Glucose 5 % rapide
- **C** Restriction hydrique
- **D** Remplir d'abord : la noradrénaline seule est contre-indiquée
- **E** Desmopressine

Q67 **SPE · Médecine intensive** **DX.12 · correction trop lente** Prise en charge · soins intensifs

Aux soins intensifs, un patient a une natrémie de 160 mmol/L. L'équipe hésite à accélérer la correction au-delà de 0,5 mmol/L/h.

Que montre la cohorte de 4265 patients citée par le cours ?

- **A** Baisse lente (≤ 0,5 mmol/L/h) : mortalité à 30 jours 50,7 % vs 31,8 %
- **B** Baisse rapide : mortalité 50,7 % vs 31,8 %
- **C** Aucune différence de mortalité
- **D** Baisse rapide : œdème cérébral chez 50 %
- **E** La cohorte portait sur l'hyponatrémie

Q68 **AP** **DX.12 · pseudo-normonatrémie** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 70 ans diabétique a une natrémie mesurée de 136 mmol/L et une glycémie de 33 mmol/L (≈ 600 mg/dL).

Quelle est sa natrémie corrigée selon Hillier ?

- **A** 136 mmol/L : pas de correction
- **B** Environ 148 mmol/L
- **C** Environ 128 mmol/L
- **D** Environ 160 mmol/L
- **E** Environ 141 mmol/L

Q69 **EX** **DX.13 vs DX.5 · PTH haute** Évaluation / diagnostic · hôpital

Une femme de 64 ans traitée pour un cancer du sein a une calcémie corrigée à 3,1 mmol/L et une PTH élevée.

Quel diagnostic faut-il retenir en premier ?

- **A** Hypercalcémie maligne humorale
- **B** Hyperparathyroïdie primaire
- **C** Métastases ostéolytiques
- **D** Lymphome à calcitriol
- **E** Intoxication à la vitamine D

Q70 **EX** **DX.13 · zolédronate** Prise en charge · hôpital

Un homme de 71 ans avec métastases osseuses a une calcémie corrigée à 3,3 mmol/L ; il a été réhydraté ; DFGe 65.

Quel schéma de zolédronate (Zometa®) l'AIPS prévoit-il ?

- **A** 4 mg IV en bolus de 1 minute
- **B** 8 mg IV unique
- **C** 4 mg par voie orale chaque jour
- **D** 120 mg SC
- **E** 4 mg IV unique, sur au moins 15 minutes

Q71 **SPE · Oncologie** **DX.13 · insuffisance rénale** Prise en charge · hôpital

Une femme de 76 ans avec cancer pulmonaire a une hypercalcémie maligne à 3,4 mmol/L ; DFGe 24 mL/min après réhydratation.

Quel antirésorptif faut-il préférer ?

- **A** Zolédronate 4 mg sans précaution
- **B** Dénosumab, en surveillant l'hypocalcémie
- **C** Calcitonine seule au long cours
- **D** Prednisone
- **E** Furosémide à haute dose

Q72 **SPE · Hématologie** **DX.13 · calcitriol** Prise en charge · hôpital

Un homme de 66 ans atteint d'un lymphome a une calcémie corrigée à 3,2 mmol/L ; PTH basse, PTHrP basse, calcitriol élevé.

Quel traitement spécifique est indiqué après la réhydratation ?

- **A** Parathyroïdectomie
- **B** Glucocorticoïde
- **C** Cinacalcet
- **D** Vitamine D
- **E** Hydrochlorothiazide

Q73 **AP** **DX.13 · calcitonine** Prise en charge · hôpital

Une femme de 59 ans a une hypercalcémie maligne à 3,7 mmol/L ; on ajoute de la calcitonine au zolédronate.

Quelle est la limite principale de la calcitonine ?

- **A** Délai d'action de 5 jours
- **B** Contre-indiquée en cas de calcémie > 3,5 mmol/L
- **C** Tachyphylaxie : effet de 48 à 72 heures
- **D** Elle provoque une hypercalcémie de rebond immédiate
- **E** Elle remplace l'hydratation

Q74 AP DX.13 · mécanisme Mécanismes · hôpital

Un homme de 61 ans avec carcinome épidermoïde pulmonaire, sans métastase osseuse, a une calcémie corrigée à 3,4 mmol/L et une PTH basse.

Quel est le mécanisme le plus probable ?

A Ostéolyse métastatique locale

B Excès de calcitriol

C Hyperparathyroïdie primaire

D Sécrétion de PTHrP

E Insuffisance rénale chronique

🚩 Pièges & alarmes · 11 Q · ce qu'il ne faut jamais rater

Point brillant, privation hydrique, desmopressine en polydipsie primaire, bicarbonate, bandelette urinaire, lithium et restriction, furosémide, calcium total.

Q75 EX DX.2 🚩hors liste · convulsion Prise en charge · urgences

Un homme de 33 ans, schizophrène, connu pour boire « des seaux d'eau », est amené après une crise convulsive. Il est confus ; pas de fièvre. Glycémie capillaire normale.

Quel examen faut-il obtenir immédiatement ?

A Natrémie

B IRM cérébrale

C Électroencéphalogramme

D Copeptine stimulée

E Lithiémie

Q76 **EX** **DX.4 vs DX.2 · point brillant** Évaluation / diagnostic · hôpital

L'IRM d'une patiente polyurique montre l'absence du point brillant de la posthypophyse. L'interne conclut à un diabète insipide central.

Quelle affirmation est correcte ?

- **A** Il manque aussi dans 39 % des polydipsies primaires
- **B** Son absence prouve le diabète insipide central
- **C** Il est toujours absent dans le diabète insipide central
- **D** Sa présence exclut le diabète insipide central
- **E** Il distingue central et néphrogénique

Q77 **EX** **DX.9 · bicarbonate** Prise en charge · urgences

Un homme de 27 ans en acidocétose a un pH de 7,08 et un bicarbonate de 8 mmol/L. L'interne veut perfuser du bicarbonate.

Quelle réponse est correcte ?

- **A** Oui : bicarbonate < 10 mmol/L
- **B** Oui, systématiquement en acidocétose sévère
- **C** Non : le bicarbonate est réservé au pH < 7,0
- **D** Oui, à la place de l'insuline
- **E** Oui, avant le remplissage

Q78 **EX** **DX.9 · euglycémique** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 31 ans, diabétique de type 1, enceinte de 30 semaines, vomit depuis 24 h. Glycémie 9 mmol/L ; β-hydroxybutyrate 4,0 mmol/L ; pH 7,21.

Quel est le diagnostic ?

- **A** Gastro-entérite simple : glycémie presque normale
- **B** Cétose de jeûne sans gravité
- **C** Syndrome hyperosmolaire
- **D** Acidose lactique
- **E** Acidocétose euglycémique

Q79 **AP** **DX.9 · bandelette** Évaluation / diagnostic · hôpital

Au cours du traitement d'une acidocétose, la cétonurie à la bandelette augmente alors que le patient s'améliore.

Comment interpréter ce résultat ?

- **A** Échec du traitement : augmenter le débit d'insuline IV
- **B** Bandelette trompeuse : suivre le BHB sanguin
- **C** Signe d'acidocétose euglycémique
- **D** Indication au bicarbonate
- **E** Critère de sortie atteint

Q80 **EX** **DX.8 · lopéramide** Prise en charge · cabinet **question négative**

Un homme de 35 ans a une diarrhée sanglante depuis 2 jours avec 39,5 °C ; il a soif et la bouche sèche, sans signe de choc.

Toutes les mesures suivantes sont appropriées, SAUF une. Laquelle ?

- **A** Réhydratation orale
- **B** Lopéramide
- **C** Coproculture
- **D** Avis infectiologique
- **E** Surveillance de la natrémie

Q81 **EX** **DX.5 vs DX.13 · furosémide** Prise en charge · hôpital

Une femme de 70 ans a une crise hypercalcémique (3,6 mmol/L) ; pas de surcharge. Un collègue propose du furosémide IV d'emblée.

Quelle réponse est correcte ?

- **A** Oui : il élimine le calcium urinaire et passe avant toute hydratation
- **B** Oui, avec une restriction hydrique
- **C** Oui, à la place du bisphosphonate
- **D** Oui, avec un thiazidique
- **E** Non : réhydrater d'abord ; furosémide seulement si surcharge

Q82 **EX** **DX.7 · restriction sous lithium** Prise en charge · cabinet

Un patient de 58 ans sous lithium a une polyurie de 6 L. Son médecin envisage de lui demander de boire 1,5 L par jour au maximum.

Quelle est la meilleure réponse ?

- **A** Oui : la restriction corrige le diabète insipide
- **B** Non : la déshydratation pousse à l'intoxication au lithium
- **C** Oui, si la lithiémie est normale
- **D** Oui, associée à la desmopressine
- **E** Oui, pour poser le diagnostic à domicile

Q83 **EX** **DX.13 · calcium total** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 74 ans dénutri, avec myélome, a un calcium total de 2,5 mmol/L et une albumine très basse ; il est confus et constipé.

Quelle est la prochaine étape ?

- **A** Conclure à une normocalcémie et chercher une autre cause
- **B** IRM hypophysaire
- **C** Restriction hydrique
- **D** Supplément de vitamine D
- **E** Calcémie corrigée ou calcium ionisé

Q84 **AP** **DX.12 · glucose 5 %** Prise en charge · hôpital

Pour corriger une hypernatrémie, un interne prescrit uniquement du glucose 5 % comme seul apport liquidien pendant 3 jours.

Quel est le problème selon l'AIPS ?

- **A** Le glucose 5 % est contre-indiqué en hypernatrémie
- **B** Il faut du NaCl 3 %
- **C** Le glucose 5 % n'apporte pas d'eau libre
- **D** Aucun problème
- **E** Le glucose 5 % ne doit jamais être le seul apport liquidien

Q85 **AP** **DX.1 · HbA1c trompeuse** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 40 ans avec une hémoglobinopathie connue a une soif et une polyurie ; son HbA1c est de 5,8 %.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Exclure le diabète sur l'HbA1c
- **B** Conclure à un prédiabète
- **C** Test de privation hydrique
- **D** Doser la glycémie veineuse
- **E** Copeptine basale

⇢ Algorithme condensé · si… alors…

Si…	Alors…
0 · Convulsion ou confusion avec boisson excessive	Natrémie immédiate ; restriction hydrique ; NaCl 3 % si symptômes graves
E1 · Glycémie ≥ 11,1 ou diabète connu, vomissements, Kussmaul	DX.9 : BHB, gaz du sang ; perfusion, potassium, insuline IV
E2 · Glycémie très haute, osmolalité > 320, cétonémie < 3,0	DX.10 : hydratation, insuline 0,05 UI/kg/h

E3 · Hypotension, tachycardie ou Na > 145	DX.12 : NaCl 0,9 % si choc ; puis eau libre ; correction lente
E4 · Ca corrigé > 3,0 et PTH basse	DX.13 : hydratation, bisphosphonate IV, calcitonine
E5 · Céphalées, trouble visuel, chirurgie hypophysaire	DX.11 : IRM de la selle, bilan hypophysaire, avis spécialisé
Ca corrigé élevé, PTH haute ou inappropriée	DX.5 : critères chirurgicaux (âge < 50 ans, T-score ≤ −2,5…)
Glycémie à jeun ≥ 7,0 ou HbA1c ≥ 6,5 %, sans crise	DX.1 : metformine et mode de vie
DFGe < 60 depuis > 3 mois	DX.3 : néphrologie, albuminurie
Lithium, diurétique ou anticholinergique récent	DX.7 : lithiémie ; arrêt ou substitution avec le prescripteur
Urine < 300 mOsm/kg ; copeptine basale ≥ 21,4	DX.4 néphrogénique : traiter la cause ; thiazide
Basale < 21,4 puis stimulée ≤ 4,9 (arginine ≤ 3,8)	DX.4 / DX.11 central : IRM ; desmopressine
Stimulée > 4,9 (arginine > 3,8)	DX.2 : restriction progressive ; TCC ; pas de desmopressine
Bouche et yeux secs sans polyurie, anti-SSA	DX.6 : score ACR/EULAR ; pilocarpine
Chaleur, fièvre ou diarrhée, urine concentrée	DX.8 : réhydratation ; surveiller la natrémie

Source : Phase A · Algorithme discriminant et §10 Arbre décisionnel.

✅ Corrigé commenté · à consulter après avoir répondu

Q1 EX DX.9 🚩E1 vs DX.12 · DX.2

✅ **B** — Glycémie, cétones et natrémie

① **Pourquoi c'est juste** Point clé du cours : un patient assoiffé et confus reçoit d'abord une glycémie capillaire, des cétones et une natrémie. Elles orientent en minutes vers l'acidocétose (E1), le syndrome hyperosmolaire (E2), l'hypernatrémie (E3) ou l'hyponatrémie par potomanie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'imagerie ne passe pas avant le contrôle métabolique en une minute au lit du malade ; elle vient si céphalées ou trouble visuel (E5).
- **C** La copeptine classe une polyurie hypotonique chez un patient stable, après avoir écarté glucose, calcium et rein.
- **D** Indispensables plus tard (E4), mais un patient assoiffé et confus reçoit d'abord glycémie, cétones et natrémie.
- **E** Dangereux chez un patient confus et hypovolémique ; sa précision n'est que de 70 à 77 %.

③ **Perle** FR à 28/min chez un buveur confus : pensez respiration de Kussmaul et prélevez un gaz du sang veineux.

④ **Source** Phase A §13 Points clés · LOT_003 audité

Q2 **EX** **DX.1 · symptômes classiques**

✅ **C** — Le diabète est établi sans second test

① **Pourquoi c'est juste** Critères ADA : une glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L avec symptômes classiques (soif, polyurie, perte de poids) pose seule le diagnostic ; sans symptôme, deux tests anormaux sont nécessaires. La soif vient de la diurèse osmotique par le glucose (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Avec des symptômes classiques, une glycémie aléatoire ≥ 11,1 mmol/L suffit seule ; la répétition vaut pour le patient asymptomatique.
- **B** Test long, utile en cas de doute ; ici le diagnostic est déjà posé.
- **D** Le prédiabète correspond à une glycémie à jeun de 5,6 à 6,9 mmol/L ou une HbA1c de 5,7 à < 6,5 %.
- **E** Une glycosurie isolée ne suffit pas au diagnostic et n'ajoute rien à une glycémie diagnostique.

③ **Perle** Avant de classer le type, écartez la crise : vomissements, Kussmaul ou confusion imposent cétones et gaz du sang.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_003 audité

Q3 **EX** **DX.4 vs DX.2 · prouver la polyurie**

✅ **C** — Diurèse de 24 h et osmolalité urinaire

① **Pourquoi c'est juste** Une polyurie se prouve par une diurèse de 24 heures supérieure à 3 litres (> 40–50 mL/kg/24 h) ; l'osmolalité urinaire sépare ensuite la diurèse osmotique (> 300 mOsm/kg) de la diurèse aqueuse (< 300 mOsm/kg : diabète insipide ou polydipsie primaire).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'IRM vient après avoir prouvé une polyurie hypotonique et orienté vers un déficit en AVP.
- **B** Test de deuxième intention : il faut d'abord prouver la polyurie et doser la copeptine basale.
- **D** Il ne distingue pas déficit en AVP et polydipsie primaire et expose à l'hyponatrémie.
- **E** Test historique, précision 70 à 77 % ; jamais en première intention.

③ **Perle** Carnet mictionnel de 3 jours = alternative au recueil de 24 heures. Le volume avant le mécanisme.

④ **Source** Phase A §7.1 Syndrome polyuro-polydipsique · LOT_003 audité

Q4 **EX** DX.2 vs DX.4 · anamnèse

✅ **D** — Polydipsie primaire

① **Pourquoi c'est juste** Début progressif, absence de nycturie et contexte psychiatrique orientent vers la polydipsie primaire (DX.2) : le polydipsique primaire dort souvent, alors que le diabète insipide persiste la nuit.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Début plutôt brutal, et la polyurie persiste la nuit avec nycturie et soif nocturne.
- **B** On le cherche sous lithium, avec hypercalcémie ou hypokaliémie ; la nycturie persiste aussi.
- **C** La glycémie est normale.
- **E** La créatinine est normale.

③ **Perle** Probable n'est pas prouvé : la copeptine (basale, puis stimulée) confirme avant toute étiquette et avant toute desmopressine.

④ **Source** Phase A §5 Anamnèse ciblée · LOT_003 audité

Q5 **EX** DX.3 · chronicité

✅ **C** — Répéter DFGe et RAC à 3 mois

① **Pourquoi c'est juste** KDIGO 2024 : IRC = DFGe < 60 mL/min/1,73 m² ou marqueur de lésion (albuminurie) pendant plus de 3 mois. Un DFGe bas isolé ne prouve pas l'IRC.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le diagnostic exige une persistance de plus de 3 mois.
- **B** L'adressage vise un DFGe < 30, une RAC > 30 mg/mmol ou un déclin rapide.
- **D** On confirme et on classe (G et A) avant de traiter.
- **E** Aucune indication sur un DFGe isolé.

③ **Perle** Une créatinine normale n'exclut pas l'IRC chez la personne âgée à faible masse musculaire.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_003 audité

Q6 EX DX.11 🚩E5 vs DX.2

✅ **E** — IRM hypophysaire urgente et bilan hypophysaire

① **Pourquoi c'est juste** Céphalées et déficit du champ visuel avec polyurie : une masse sellaire ou hypothalamique comprime le chiasma (DX.11, rang E5). IRM urgente, bilan hypophysaire complet, avis endocrinologique et neurochirurgical.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il ne tranche pas et retarde le diagnostic d'une masse qui comprime le chiasma.
- **B** Peu précis et dangereux ; il ne répond pas à la question de la masse.
- **C** Céphalées + déficit du champ visuel = drapeau rouge E5 : pas d'attente.
- **D** Le rein n'explique ni les céphalées ni le champ visuel.

③ **Perle** Début brutal = déficit en AVP plutôt que polydipsie primaire. Cherchez aussi un panhypopituitarisme.

④ **Source** Phase A §4 Démarche, E5 · LOT_003 audité

Q7 EX DX.12 🚩E3 vs DX.8

✅ **A** — Cristalloïde isotonique en bolus

① **Pourquoi c'est juste** Le médecin traite le choc avant de corriger la natrémie : cristalloïde isotonique quelle que soit la natrémie, jusqu'à la restauration du volume (malgré la contre-indication de l'étiquette AIPS, à discuter) ; puis eau libre sur 48 à 72 heures (DX.12, E3).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'eau libre vient après la restauration du volume ; elle ne corrige pas le choc.
- **C** Contre-indiquée seule dans l'hypotension par hypovolémie : remplir d'abord.
- **D** Trop lent pour un choc ; c'est une étape de correction du déficit en eau.
- **E** Le soluté hypotonique vient après la restauration du volume.

③ **Perle** Une pression normale n'exclut pas le choc : la compensation retarde l'hypotension. Au-delà de 160 mmol/L, la mortalité de l'adulte atteint 75 %.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_003 audité

Q8 EX DX.13 🚩E4 vs DX.5

✅ **C** — Réhydratation par NaCl 0,9 %, puis antirésorptif IV

① **Pourquoi c'est juste** Calcémie corrigée > 3,0 mmol/L avec PTH basse chez un cancéreux = hypercalcémie maligne (DX.13, E4). Ordre : hydratation par sérum physiologique, puis bisphosphonate IV (zolédronate) ; calcitonine si sévère.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'AIPS exige de contrôler l'état d'hydratation avant le zolédronate.
- **B** Effet court (48 à 72 h) ; elle complète l'antirésorptif dans les formes sévères.
- **D** Réservée à l'hypercalcémie par calcitriol (lymphome, granulomatose).
- **E** PTH basse : la parathyroïde n'est pas en cause.

③ **Perle** Furosémide seulement en cas de surcharge, jamais en routine. Au-delà de 3,5 mmol/L : ajouter la calcitonine et surveiller l'ECG.

④ **Source** Phase B DX.13 §13 · LOT_003 audité

Q9 EX DX.10 🚩E2 vs DX.9

✅ **A** — Syndrome hyperosmolaire hyperglycémique

① **Pourquoi c'est juste** Glycémie très élevée (≥ 30–33,3 mmol/L), osmolalité ≥ 320 mOsm/kg, hypovolémie, cétonémie < 3,0 mmol/L et pH ≥ 7,30 = syndrome hyperosmolaire hyperglycémique (DX.10, E2), typique du diabétique âgé, installé sur plusieurs jours.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Exige β-hydroxybutyrate ≥ 3,0 mmol/L et pH < 7,30 ou bicarbonate < 18 mmol/L.
- **C** Il faudrait une cétonémie > 3,0 mmol/L et une acidose.
- **D** La glycémie de 41 mmol/L explique l'hyperosmolalité.
- **E** Une confusion récente avec glycémie extrême n'est pas une démence.

③ **Perle** Le diagnostic n'est jamais biologique seul : l'hypovolémie clinique fait partie des critères.

④ **Source** Phase B DX.10 §13 · LOT_003 audité

Q10 **EX** DX.9 🚩E1 · ordre

✅ **E** — NaCl 0,9 % 500 à 1000 mL/h

① **Pourquoi c'est juste** Acidocétose (glycémie ≥ 11,1, β-hydroxybutyrate ≥ 3,0, pH < 7,30) : l'ordre est perfusion, potassium, insuline. Le remplissage (500–1000 mL/h pendant 2 à 4 h) débute d'emblée ; il restaure la volémie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La kaliémie doit être connue avant la première unité ; < 3,5 mmol/L, l'insuline se retarde.
- **B** Réservé au pH < 7,0.
- **C** Il s'ajoute seulement quand la glycémie passe sous 13,9 mmol/L.
- **D** Acidocétose modérée : hospitalisation et insuline IV.

③ **Perle** Gravité : pH 7,0–7,25 = modérée (soins intermédiaires) ; pH < 7,0 = sévère. Cherchez le déclencheur : infection, oubli d'insuline.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_003 audité

Q11 **EX** DX.5 vs DX.13 · confirmer

✅ **B** — Recontrôler calcémie et PTH à ≥ 2 semaines

① **Pourquoi c'est juste** Hyperparathyroïdie primaire (DX.5) : calcémie corrigée élevée avec PTH élevée ou inappropriée, sur deux mesures espacées d'au moins 2 semaines. L'hypercalcémie rend le tubule résistant à l'AVP : d'où la polyurie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'imagerie localise avant la chirurgie ; elle ne pose ni n'écarte le diagnostic.
- **C** La PTHrP cherche une hypercalcémie maligne, à PTH basse.
- **D** Le diagnostic biochimique doit d'abord être confirmé.
- **E** Réservé à l'hypercalcémie maligne (calcémie corrigée > 3,0 mmol/L).

③ **Perle** Une PTH « normale » avec une calcémie haute est inappropriée : elle n'exclut pas la maladie.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_003 audité

Q12 **EX** **DX.6 vs DX.4 · soif sans polyurie**

✅ **B** — Revoir les médicaments, puis anti-SSA et tests de sécheresse

① **Pourquoi c'est juste** La soif du syndrome sec naît de la bouche, pas de l'osmolalité : elle ne s'accompagne pas de polyurie. Un syndrome sec persistant impose d'abord la revue des médicaments (anticholinergiques), puis l'anti-SSA et les tests de sécheresse (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans polyurie, il n'y a pas de diabète insipide à chercher.
- **C** Il explore une polyurie hypotonique, absente ici.
- **D** Aucun signe de lésion sellaire ni de polyurie.
- **E** Aucune polyurie à traiter ; risque d'hyponatrémie.

③ **Perle** Seul le volume urinaire sépare la xérostomie du syndrome polyuro-polydipsique : mesurez-le.

④ **Source** Phase B DX.6 §13 · LOT_003 audité

Q13 **EX** **DX.7 vs DX.4 · lithium**

✅ **A** — Lithiémie, avec natrémie, calcémie et créatinine

① **Pourquoi c'est juste** Un patient sous lithium qui boit et urine beaucoup a un diabète insipide néphrogénique jusqu'à preuve du contraire (DX.7). La lithiémie dit s'il existe un surdosage ; l'arrêt ou la substitution se discute avec le prescripteur.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Le lithium cause un diabète insipide néphrogénique, pas une lésion sellaire.
- **C** Pas de restriction thérapeutique sous lithium : la déshydratation pousse à l'intoxication.
- **D** Le néphrogénique se signe par une copeptine basale élevée ; il faut d'abord la lithiémie.
- **E** Elle ne corrige pas le diabète insipide du lithium : le rein ne répond plus à l'ADH.

③ **Perle** Lithiémie ≥ 1,5 mmol/L = arrêt immédiat. Prélèvement 12 h après la dernière prise.

④ **Source** Phase B DX.7 §13 · LOT_003 audité

Q14 **EX** **DX.8 · coup de chaleur**

✅ **D** — Refroidissement immédiat par immersion dans l'eau

① **Pourquoi c'est juste** Coup de chaleur = température centrale > 40 °C avec dysfonction du système nerveux central. Il impose le refroidissement immédiat ; l'immersion dans l'eau (1 à 17 °C) est la meilleure technique (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Insuffisant : > 40 °C avec confusion définit un coup de chaleur.
- **B** Le refroidissement ne se retarde pas pour un résultat.
- **C** L'eau libre ne refroidit pas ; le danger immédiat est la température.
- **E** Contraire au besoin : il a perdu de l'eau.

③ **Perle** Soif + chaleur + urine concentrée = déshydratation ; ajoutez la confusion et la fièvre > 40 °C = coup de chaleur.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_003 audité

Q15 **EX** **DX.4 néphrogénique vs DX.2**

✅ **B** — Chercher lithium, hypercalcémie, hypokaliémie

① **Pourquoi c'est juste** Copeptine basale ≥ 21,4 pmol/L sans soif imposée (sensibilité et spécificité 100 %) = diabète insipide néphrogénique (DX.4). On recherche la cause : lithium, hypercalcémie, hypokaliémie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Inutile : une copeptine basale ≥ 21,4 pmol/L conclut déjà.
- **C** Même raison : le test stimulé ne sert que si la basale est < 21,4 pmol/L.
- **D** Le néphrogénique est rénal ; l'IRM sert au déficit central.
- **E** Le rein résiste à l'AVP : la desmopressine ne corrige pas un néphrogénique.

③ **Perle** 200 à 300 mL d'eau dans l'heure précédente suffisent à faire chuter la copeptine : pas de boisson avant le prélèvement.

④ **Source** Phase A §9.d Deuxième intention · LOT_003 audité

Q16 EX DX.1 · prédiabète

✅ **A** — Prédiabète

① **Pourquoi c'est juste** Prédiabète : HbA1c 5,7 à < 6,5 % ou glycémie à jeun 5,6 à 6,9 mmol/L. Une valeur isolée sans symptôme ne pose jamais le diagnostic de diabète (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il faut HbA1c ≥ 6,5 % ou glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L.
- **C** Aucune valeur n'atteint un seuil diagnostique.
- **D** HbA1c entre 5,7 et < 6,5 % et glycémie à jeun 5,6–6,9 mmol/L ne sont pas normales.
- **E** Le diabète insipide ne touche pas la glycémie.

③ **Perle** Diabète : HbA1c ≥ 6,5 % (48 mmol/mol), glycémie à jeun ≥ 7,0 mmol/L, HGPO 2 h ≥ 11,1 mmol/L ; deux tests anormaux sans symptôme.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_003 audité

Q17 EX DX.1 vs DX.3 · metformine

✅ **E** — Elle est contre-indiquée chez cette patiente

① **Pourquoi c'est juste** AIPS Glucophage® : contre-indiquée si DFGe < 30 mL/min/1,73 m², en acidocétose ou en coma diabétique (DX.1). Les recommandations suisses (SSED) placent la metformine en premier, puis un inhibiteur du SGLT2 ou un agoniste du GLP-1.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiquée en dessous d'un DFGe de 30 mL/min/1,73 m².
- **B** Ce plafond vaut pour un DFGe de 30 à 59.
- **C** Dose maximale hors insuffisance rénale.
- **D** Aucun rapport avec la question rénale.

③ **Perle** Les sulfonylurées ne sont plus recommandées par la SSED.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_003 audité

Q18 SPE · Endocrinologie DX.1 · DFGe 30–59

✅ **D** — 1000 mg

① **Pourquoi c'est juste** AIPS Glucophage® : DFGe 30 à 59 → maximum 1000 mg par jour ; arrêt si < 30.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Trop bas : le palier DFGe 30–59 autorise jusqu'à 1000 mg.
- **B** Dose d'entretien habituelle, hors insuffisance rénale.
- **C** Maximum hors insuffisance rénale.
- **E** L'arrêt s'impose sous 30 mL/min/1,73 m^2.

③ **Perle** Effet glycémique de l'empagliflozine réduit si DFGe < 45 : l'iSGLT2 garde surtout un bénéfice rénal et cardiaque.

④ **Source** Phase B DX.1 §11 · LOT_003 audité

Q19 AP DX.1 vs DX.9 · iSGLT2

✅ **E** — Doser les cétones (β-hydroxybutyrate) et le pH

① **Pourquoi c'est juste** AIPS Jardiance® : des nausées chez un diabétique imposent un test de cétones quelle que soit la glycémie, et l'arrêt si l'acidocétose est suspectée. Environ 10 % des acidocétoses sont euglycémiques (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sous iSGLT2, l'acidocétose survient avec une glycémie modérée.
- **B** On l'arrête si l'acidocétose est suspectée.
- **C** Elle mesure l'acétoacétate et sous-estime la cétose au début.
- **D** Le tableau impose d'exclure une acidocétose.

③ **Perle** Glycémie normale ≠ acidocétose exclue : β-hydroxybutyrate et gaz du sang.

④ **Source** Phase B DX.1 §14 · LOT_003 audité

Q20 **EX** **DX.2 vs DX.4 · copeptine stimulée**

✅ **A** — Polydipsie primaire

① **Pourquoi c'est juste** Copeptine stimulée par NaCl 3 % (Na > 147 mmol/L) > 4,9 pmol/L = polydipsie primaire (sensibilité 93 %, spécificité 100 %, précision 97 %). ≤ 4,9 = diabète insipide central (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il faudrait une copeptine stimulée ≤ 4,9 pmol/L.
- **C** Il faudrait une copeptine basale ≥ 21,4 pmol/L.
- **D** La zone limite va de 4,9 à 6,5 pmol/L.
- **E** La créatinine est normale.

③ **Perle** Entre 4,9 et 6,5 pmol/L (seuil post hoc 6,5) : avis endocrinologique, répéter ou croiser avec la clinique.

④ **Source** Phase A §9.d Interprétation de la copeptine · LOT_003 audité

Q21 **EX** **DX.2 · desmopressine**

✅ **B** — Refuser la desmopressine : elle est contre-indiquée

① **Pourquoi c'est juste** Dans la polydipsie primaire (DX.2), la desmopressine provoque une hyponatrémie : l'AIPS la contre-indique. Aucun traitement n'est validé : réduction progressive des apports, psychoéducation, TCC.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose du diabète insipide central ; contre-indiquée ici.
- **C** Traitement du diabète insipide néphrogénique.
- **D** On réduit les apports progressivement.
- **E** Un essai ne distingue pas les deux entités et expose à l'hyponatrémie.

③ **Perle** Dire « boire à la soif », non « boire beaucoup » : c'est aussi la prévention primaire de la potomanie.

④ **Source** Phase A §11.B.2 Pharmacologique · LOT_003 audité

Q22 AP DX.2 · faibles solutés

✅ **E** — L'apport faible de solutés réduit l'excrétion d'eau à environ 4 L/jour

① **Pourquoi c'est juste** Un rein normal excrète 15 à 18 L d'eau par jour ; quand l'apport de solutés baisse (malnutrition, bière), cette capacité tombe à 4 L par jour. Au-delà, l'eau s'accumule et la natrémie chute (DX.2, hors liste).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le facteur clé est la baisse de l'apport de solutés.
- **B** Ce n'est pas le mécanisme décrit.
- **C** Un rein normal excrète jusqu'à 15 à 18 L par jour.
- **D** Aucune diarrhée n'est décrite.

③ **Perle** Médicaments, infection et stress libèrent l'AVP et aggravent le risque.

④ **Source** Phase A §3 Complications · LOT_003 audité

Q23 SPE · Psychiatrie DX.2 · correction prudente

✅ **D** — 8 mmol/L

① **Pourquoi c'est juste** Hyponatrémie par potomanie : NaCl 3 % seulement si symptômes graves ; hausse ≤ 10 mmol/L en 24 h, 8 mmol/L si le risque de démyélinisation osmotique est élevé (alcool, dénutrition).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Limite habituelle ; elle descend à 8 mmol/L si le risque de démyélinisation osmotique est élevé.
- **B** Limite citée pour la myélinolyse, trop haute chez ce patient à risque.
- **C** Expose à la démyélinisation osmotique.
- **E** Même en urgence, la correction reste limitée.

③ **Perle** Pesée quotidienne du polydipsique : une prise rapide signe la rétention d'eau.

④ **Source** Phase A §11.B.1 Hyponatrémie par potomanie · LOT_003 audité

Q24 EX DX.3 · hyperkaliémie

✅ **D** — Gluconate de calcium IV

① **Pourquoi c'est juste** Hyperkaliémie avec modifications ECG = urgence : le calcium IV vient d'abord, il protège le myocarde (DX.3). Les autres mesures suivent.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il ne protège pas le myocarde dans l'immédiat.
- **B** Trop lente devant un ECG anormal.
- **C** Un ECG anormal est une urgence immédiate.
- **E** Ne protège pas le myocarde.

③ **Perle** Oligo-anurie, hyperkaliémie avec ECG ou œdème pulmonaire en IRC = traitement d'urgence.

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_003 audité

Q25 EX DX.3 · polyurie de l'IRC

✅ **C** — Perte de la capacité tubulaire de concentrer l'urine

① **Pourquoi c'est juste** Dans l'IRC (DX.3), les tubules perdent leur capacité de concentrer l'urine : polyurie modérée et nycturie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La glycémie est normale.
- **B** Le défaut est rénal, pas hypophysaire.
- **D** Le mécanisme de l'IRC est tubulaire.
- **E** La calcémie est normale.

③ **Perle** Une créatinine normale n'exclut pas l'IRC chez la personne âgée à faible masse musculaire.

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_003 audité

Q26 **AP** **DX.3 · stade KDIGO**

✅ **C** — G3a A2

① **Pourquoi c'est juste** KDIGO 2024 : G3a = DFGe 45–59 ; A2 = RAC 3 à 30 mg/mmol. La combinaison G et A estime le risque (DX.3).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** DFGe 60–89 et RAC < 3.
- **B** G3b correspond à un DFGe de 30 à 44.
- **D** A3 correspond à une RAC > 30 mg/mmol.
- **E** Plus de 3 mois de persistance : l'IRC est établie.

③ **Perle** Albuminurie seule (RAC ≥ 3 mg/mmol) persistante suffit au diagnostic, même avec un DFGe normal.

④ **Source** Phase B DX.3 §8 · LOT_003 audité

Q27 **AP** **DX.3 · iSGLT2**

✅ **D** — La dapagliflozine ne s'instaure pas sous 25 mL/min/1,73 m²

① **Pourquoi c'est juste** AIPS : instauration non recommandée si DFGe < 25 pour la dapagliflozine (Forxiga®), < 20 pour l'empagliflozine. Bloqueur du SRA + iSGLT2 ralentissent la progression en cas d'albuminurie (DX.3).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'empagliflozine s'instaure dès 20, la dapagliflozine dès 25.
- **B** Son seuil d'instauration est 20 mL/min/1,73 m².
- **C** Son seuil est 25 mL/min/1,73 m².
- **E** Ils ralentissent la progression de l'IRC avec albuminurie.

③ **Perle** IEC et statine sont contre-indiqués pendant la grossesse ; l'iSGLT2 s'arrête dès la grossesse constatée.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_003 audité

Q28 **SPE · Néphrologie** **DX.3 · anémie rénale**

✅ **A** — 120 g/L au plus

① **Pourquoi c'est juste** AIPS Aranesp® : hémoglobine maintenue à 120 g/L (12 g/dL) au plus ; baisse d'environ 25 % de la dose si elle monte de plus de 20 g/L en 4 semaines.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Trop bas : la limite AIPS est 120 g/L.
- **C** Au-dessus de la limite AIPS.
- **D** Au-dessus de la limite AIPS.
- **E** L'AIPS fixe un plafond.

③ **Perle** Dose initiale 0,45 µg/kg par semaine, IV chez le dialysé, SC chez le non-dialysé.

④ **Source** Phase B DX.3 §11 · LOT_003 audité

Q29 **EX** **DX.4 vs DX.2 · natrémie**

✅ **A** — Diabète insipide, sans test supplémentaire

① **Pourquoi c'est juste** Un sodium ≥ 150 mmol/L avec urine diluée confirme le diabète insipide sans test supplémentaire (DX.4). Le test stimulé sert quand la natrémie est normale.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** La polydipsie primaire a une natrémie normale-basse.
- **C** Inutile : Na ≥ 150 avec urine diluée confirme déjà le diabète insipide.
- **D** Dangereux avec une natrémie déjà haute.
- **E** Une urine à 110 mOsm/kg est diluée, pas osmotique.

③ **Perle** Natrémie normale chez un diabète insipide qui a accès à l'eau ; haute seulement si adipsie ou eau inaccessible.

④ **Source** Phase B DX.4 §13 · LOT_003 audité

Q30 EX DX.4 néphrogénique · traitement

✅ **C** — Hydrochlorothiazide

① **Pourquoi c'est juste** Diabète insipide néphrogénique (DX.4) : supprimer la cause, corriger calcium et potassium, puis hydrochlorothiazide (100 mg/j en 2 à 4 prises, kaliémie étroitement surveillée). Paradoxe : le thiazide réduit le volume urinaire et augmente l'osmolalité urinaire.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le rein résiste à l'AVP : sans effet dans le néphrogénique.
- **B** Expose à la déshydratation et à l'hypernatrémie.
- **D** Diurétique de l'anse : pas l'indication AIPS du néphrogénique.
- **E** Traite la xérostomie, pas la polyurie.

③ **Perle** Sous lithium, le thiazide élève la lithiémie : choix discuté avec le prescripteur.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_003 audité

Q31 AP DX.4 · privation hydrique

✅ **E** — Sa précision n'est que de 41 % pour la polydipsie primaire

① **Pourquoi c'est juste** La privation hydrique (1964) reste un étalon historique : précision 70 à 77 %, et seulement 41 % pour la polydipsie primaire. La copeptine stimulée par NaCl 3 % atteint 96,5 % (DX.4 vs DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La copeptine stimulée le surpasse : 96,5 % contre 76,6 %.
- **B** Elle est de 70 à 77 %.
- **C** Il ne l'est pas.
- **D** Il expose à des complications graves dans le diabète insipide.

③ **Perle** Ce qui ne suffit pas : polyurie seule, urine diluée seule, essai de desmopressine.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_003 audité

Q32 **AP** **DX.4 · enfant**

✅ **A** — Test à l'arginine

① **Pourquoi c'est juste** Chez l'enfant, le NaCl 3 % est contre-indiqué : on préfère l'arginine (seuil 3,8 pmol/L à 60 minutes). Le test à l'arginine dure 1 heure et demande moins de surveillance.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Contre-indiqué chez l'enfant.
- **C** Moins précis et non validé de façon prospective.
- **D** Ne distingue pas central et polydipsie primaire.
- **E** Une basale < 21,4 pmol/L impose un test stimulé.

③ **Perle** Vomissements pendant l'arginine : test invalide, sauf si la copeptine reste basse.

④ **Source** Phase A §9.c Alternatives · LOT_003 audité

Q33 **AP** **DX.4 · desmopressine du sujet âgé**

✅ **C** — Avant le début et 3 jours après

① **Pourquoi c'est juste** Après 65 ans : natrémie avant le début, puis 3 jours après le début ou après chaque hausse de dose. Chez des adultes de 70 ans, la desmopressine multiplie par 13 le taux d'hyponatrémie (DX.4).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Trop tard : l'hyponatrémie survient tôt.
- **B** La natrémie reste obligatoire après 65 ans.
- **D** Insuffisant au début.
- **E** La surveillance prévient les symptômes.

③ **Perle** Prise de poids ou signes d'hyponatrémie sous desmopressine : interrompre (AIPS).

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_003 audité

Q34 **SPE · Endocrinologie pédiatrique** DX.4 vs DX.11 · étiologie

✅ **C** — Craniopharyngiome ou germinome

① **Pourquoi c'est juste** Un diabète insipide isolé ne fait pas suspecter un adénome hypophysaire, qui en donne rarement : on pense au craniopharyngiome ou au germinome (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'adénome donne rarement un diabète insipide.
- **B** Elle donne une polyurie néphrogénique, pas un déficit central.
- **D** Le lithium cause un néphrogénique.
- **E** Le déficit central est confirmé.

③ **Perle** Bilan hypophysaire complet : chaque lésion de l'axe peut toucher plusieurs hormones.

④ **Source** Phase B DX.4 §14 · LOT_003 audité

Q35 **EX** DX.5 · critère chirurgical

✅ **E** — Parathyroïdectomie, car elle a moins de 50 ans

① **Pourquoi c'est juste** Critères chirurgicaux chez l'asymptomatique (Ve atelier, 2022), un seul suffit : âge < 50 ans, calcémie > 0,25 mmol/L au-dessus de la norme, T-score ≤ −2,5 ou fracture vertébrale, DFGe < 60, calcul, hypercalciurie (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'âge < 50 ans suffit comme critère.
- **B** Réservé à l'hyperparathyroïdie non opérable.
- **C** On recommande 800 à 1000 mg par jour.
- **D** Il traite l'hypercalcémie maligne.

③ **Perle** Signes neurocognitifs et qualité de vie ne sont pas des critères opératoires.

④ **Source** Phase B DX.5 §8 · LOT_003 audité

Q36 AP DX.5 vs HHF · clairance

✅ **A** — Hypercalcémie hypocalciurique familiale

① **Pourquoi c'est juste** Rapport de clairance < 0,01 : hypercalcémie hypocalciurique familiale, où la chirurgie est contre-indiquée ; > 0,02 : forme primaire ; zone grise pour 40 % des patients (DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Un rapport > 0,02 l'évoque ; < 0,01 évoque l'HHF.
- **C** La PTH n'est pas basse.
- **D** Elle donne une PTH basse.
- **E** Sans rapport avec la calcémie.

③ **Perle** Thiazidiques et lithium peuvent simuler ou aggraver une hyperparathyroïdie.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_003 audité

Q37 SPE · Endocrinologie DX.5 · cinacalcet

✅ **B** — 30 mg 2 fois par jour ; calcémie à 1 semaine

① **Pourquoi c'est juste** AIPS : 30 mg 2 fois par jour, paliers de 2 à 4 semaines jusqu'à 90 mg 3 à 4 fois par jour ; calcémie 1 semaine après le début puis tous les 2 à 3 mois. Contre-indication : hypocalcémie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose maximale atteinte par paliers de 2 à 4 semaines.
- **C** Pas le schéma AIPS.
- **D** La calcémie se contrôle 1 semaine après le début.
- **E** Contrôle trop tardif : 1 semaine, puis tous les 2 à 3 mois.

③ **Perle** Alerte : calcémie < 2,1 mmol/L ou symptômes d'hypocalcémie.

④ **Source** Phase A §11.C Surveillance · LOT_003 audité

Q38 EX DX.6 · score ACR/EULAR

✅ **E** — 4 points : syndrome de Sjögren classé

① **Pourquoi c'est juste** ACR/EULAR 2016 : anti-SSA 3 ; sialadénite focale 3 ; OSS ≥ 5 : 1 ; Schirmer ≤ 5 mm/5 min : 1 ; débit salivaire ≤ 0,1 mL/min : 1. Score ≥ 4 = classé (sensibilité 96 %, spécificité 95 %) (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le Schirmer ≤ 5 mm ajoute 1 point aux 3 de l'anti-SSA.
- **B** L'anti-SSA vaut 3, le Schirmer 1.
- **C** L'anti-SSA vaut à lui seul 3 points.
- **D** Le seuil de 4 est atteint sans elle.

③ **Perle** Ce sont des critères de classification, non de diagnostic clinique.

④ **Source** Phase B DX.6 §8 · LOT_003 audité

Q39 EX DX.6 · pilocarpine

✅ **A** — 5 mg 4 fois par jour, pendant les repas

① **Pourquoi c'est juste** AIPS Salagen® (Sjögren) : 5 mg 4 fois par jour pendant les repas ; effet complet en 6 semaines ; arrêt sans amélioration après 2 à 3 mois ; sudation chez environ 50 % (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Dose insuffisante selon l'AIPS.
- **C** Dose maximale citée après radiothérapie, pas le schéma du Sjögren.
- **D** Au-dessus du schéma AIPS.
- **E** Schéma après radiothérapie ORL.

③ **Perle** Soins buccodentaires et substituts salivaires complètent le traitement.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_003 audité

Q40 **AP** **DX.6 · anti-SSA seul**

✅ **C** — Score de 3 : critères non atteints

① **Pourquoi c'est juste** Un anti-SSA seul (3 points) ou une biopsie seule (3 points) n'atteint pas 4 ; les trois tests de sécheresse totalisent 3 points (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Seul l'anti-SSA compte ici (3 points).
- **B** Ils ne comptent pas dans le score.
- **D** Une biopsie focale (3 points) pourrait compléter.
- **E** La bouche sèche ne crée pas de polyurie.

③ **Perle** Exclusions : radiothérapie cervicale, hépatite C active, VIH avancé, sarcoïdose, amylose, GvH, maladie IgG4.

④ **Source** Phase B DX.6 §8 · LOT_003 audité

Q41 **AP** **DX.6 · lymphome**

✅ **A** — Lymphome

① **Pourquoi c'est juste** Une tuméfaction parotidienne dure ou persistante, des adénopathies, des cryoglobulines ou un C4 bas font redouter un lymphome dans le Sjögren (DX.6).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Une parotide dure et persistante n'est pas une simple poussée.
- **C** Aucun lien avec une masse parotidienne.
- **D** Sans rapport.
- **E** Elle provoque une sudation, pas une masse.

③ **Perle** Un purpura impose aussi la recherche d'une vascularite.

④ **Source** Phase B DX.6 §14 · LOT_003 audité

Q42 EX DX.7 · lithiémie

✅ **D** — 0,6 à 1,0 mmol/L, 12 heures après la dernière prise

① **Pourquoi c'est juste** AIPS Lithiofor® : lithiémie cible 0,6 à 1,0 mmol/L, prélevée 12 heures après la dernière prise ; hebdomadaire le 1er mois puis tous les 2 mois. Polyurie et soif chez 30 à 50 % au début (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le prélèvement se fait 12 heures après la dernière prise.
- **B** 1,5 mmol/L est le seuil toxique.
- **C** En dessous de la cible thérapeutique.
- **E** La lithiémie est hebdomadaire le premier mois.

③ **Perle** Polydipsie ou polyurie sous lithium : arrêter et consulter (AIPS).

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_003 audité

Q43 EX DX.7 vs DX.4 · desmopressine

✅ **A** — Inefficace : le rein ne répond plus à l'ADH

① **Pourquoi c'est juste** La desmopressine ne corrige pas le diabète insipide du lithium, car le rein ne répond plus à l'ADH (DX.7). Le thiazide a l'indication AIPS du néphrogénique, mais il élève la lithiémie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** C'est le schéma du diabète insipide central.
- **C** L'hyponatrémie contre-indique la desmopressine.
- **D** Le rein résiste à l'AVP : elle n'agit pas.
- **E** Pas de restriction thérapeutique sous lithium.

③ **Perle** Sous lithium : bouche sèche + natrémie normale = soif anticholinergique, pas diabète insipide.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_003 audité

Q44 **SPE · Psychiatrie** DX.7 · interactions

✅ **C** — Hausse de la lithiémie

① **Pourquoi c'est juste** AINS, IEC, sartans, diurétiques de l'anse, épargneurs de potassium et thiazidiques font monter la lithiémie : contrôle rapproché ou alternative avec le prescripteur (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** AINS et IEC la font monter.
- **B** Le lithium agit sur le rein, pas sur l'hypophyse.
- **D** Sans rapport avec ces médicaments.
- **E** AINS, IEC, sartans et diurétiques élèvent la lithiémie.

③ **Perle** Toxicité attendue dès 1,5 mmol/L, parfois plus bas chez le sujet sensible.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_003 audité

Q45 **SPE · Néphrologie** DX.7 · dialyse

✅ **C** — Dialyse

① **Pourquoi c'est juste** La dialyse est recommandée si la lithiémie dépasse 4,0 mEq/L avec insuffisance rénale, ou si la conscience baisse, quel que soit le taux (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le lithium s'arrête ; le taux et l'insuffisance rénale imposent la dialyse.
- **B** Il élève la lithiémie.
- **D** Sans effet sur l'intoxication.
- **E** Urgence immédiate.

③ **Perle** La déshydratation pousse à l'intoxication au lithium : pas de restriction hydrique.

④ **Source** Phase B DX.7 §11 · LOT_003 audité

Q46 AP DX.7 · anticholinergique

✅ **B** — Bouche sèche médicamenteuse

① **Pourquoi c'est juste** Les anticholinergiques assèchent la bouche : la soif naît de la bouche, sans polyurie (DX.7). Critères d'imputabilité : chronologie, mécanisme connu, régression à l'arrêt, autres causes écartées.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sans polyurie, pas de diabète insipide.
- **C** La chronologie médicamenteuse et l'absence de polyurie orientent ailleurs.
- **D** Aucune hyperglycémie décrite.
- **E** La natrémie est normale.

③ **Perle** Arrêt ou substitution avec le prescripteur.

④ **Source** Phase B DX.7 §8 · LOT_003 audité

Q47 EX DX.8 · enfant déshydraté

✅ **E** — Solution orale hypoosmolaire, 100 mL/kg en 6 heures

① **Pourquoi c'est juste** Solution de réhydratation orale hypoosmolaire en première intention : 50 mL/kg en 6 h si perte < 5 %, 100 mL/kg en 6 h si 5 à 10 % (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Volume de la perte < 5 %.
- **B** Le choc n'est pas présent ; l'oral est la première intention.
- **C** Sans sels : pas une réhydratation adaptée.
- **D** Pas de traitement de la déshydratation.

③ **Perle** Perte de poids de l'enfant : < 5 % légère, 5 à 10 % moyenne.

④ **Source** Phase B DX.8 §11 · LOT_003 audité

Q48 **AP** **DX.8 · définition**

✅ **D** — Déshydratation par perte d'eau établie

① **Pourquoi c'est juste** Déshydratation par perte d'eau : osmolalité sérique ≥ 295 mOsm/kg (Cochrane 2015) ; 295–300 = imminente, > 300 = établie (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Aucun signe clinique isolé n'est fiable chez le sujet âgé.
- **B** 295 à 300 = imminente ; > 300 = établie.
- **C** Le tableau est une perte d'eau.
- **E** La bouche sèche s'explique par la déshydratation biologique.

③ **Perle** Couleur des urines, bouche sèche et soif n'atteignent pas le seuil d'utilité chez les ≥ 65 ans (sensibilité 60 %, spécificité 75 %).

④ **Source** Phase B DX.8 §8 · LOT_003 audité

Q49 **AP** **DX.8 · signe isolé**

✅ **A** — Non, aucun signe clinique isolé n'est fiable

① **Pourquoi c'est juste** Chez les 65 ans et plus, aucun signe isolé (couleur, densité et volume urinaires, FC, bouche sèche, soif) n'atteint le seuil d'utilité : on mesure l'osmolalité sérique (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Sensibilité 60 %, spécificité 75 % au mieux.
- **C** La soif est aussi peu fiable chez le sujet âgé.
- **D** La couleur des urines n'atteint pas le seuil d'utilité.
- **E** On mesure l'osmolalité sérique.

③ **Perle** Prévention : proposer des boissons régulières aux personnes âgées en cas de chaleur.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_003 audité

Q50 EX DX.9 · potassium

✅ **B** — Potassium 10 mmol/h ; retarder l'insuline jusqu'à K > 3,5

① **Pourquoi c'est juste** Acidocétose (DX.9) : potassium mesuré avant l'insuline ; < 3,5 mmol/L retarde l'insuline et impose du chlorure de potassium à 10 mmol/h ; entre 3,5 et 5,0, ajouter 20 à 30 mmol par litre.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Sous 3,5 mmol/L de kaliémie, l'insuline se retarde : le potassium d'abord.
- **C** Réservé au pH < 7,0.
- **D** Le remplissage se poursuit.
- **E** Sous 3,5 mmol/L, le potassium vient d'abord.

③ **Perle** AIPS du KCl : max 10 mmol/h, 40 mmol/L, 200 mmol/j si K > 2,5 mmol/L.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_003 audité

Q51 EX DX.9 · glucose

✅ **D** — Ajouter glucose 5–10 % et réduire l'insuline à 0,05 UI/kg/h

① **Pourquoi c'est juste** Sous 13,9 mmol/L de glycémie : ajouter glucose 5–10 % et réduire l'insuline à 0,05 UI/kg/h pour continuer à éteindre la cétose (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La cétose persiste ; l'insuline continue avec du glucose.
- **B** Les critères de résolution ne sont pas atteints.
- **C** Risque d'hypoglycémie ; la cible est la cétose.
- **E** pH > 7,0.

③ **Perle** La guérison se juge sur le β-hydroxybutyrate et le pH, pas sur la glycémie.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_003 audité

Q52 EX DX.9 · résolution

✅ **D** — Relais sous-cutané avec chevauchement de 1 à 2 heures

① **Pourquoi c'est juste** Résolution : β-hydroxybutyrate < 0,6 mmol/L et pH ≥ 7,30 ou bicarbonate ≥ 18 mmol/L. Relais sous-cutané avec chevauchement de 1 à 2 heures (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'acidocétose est résolue.
- **B** Sans chevauchement, la cétose récidive.
- **C** La bandelette urinaire mesure l'acétoacétate et trompe.
- **E** Il n'est pas un critère de guérison.

③ **Perle** Sortie : relais établi, alimentation reprise, cause traitée, éducation et suivi planifiés.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_003 audité

Q53 SPE · Pédiatrie DX.9 · œdème cérébral de l'enfant

✅ **C** — Mannitol IV 0,5 à 1 g/kg

① **Pourquoi c'est juste** L'œdème cérébral tue l'enfant en acidocétose (0,4 % en Suisse) : mannitol 0,5 à 1 g/kg en 10 à 15 minutes dès la suspicion (ou NaCl 3 % 2,5 à 5 mL/kg), puis imagerie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'imagerie ne doit jamais retarder le traitement.
- **B** On réduit le débit, sans hypotension.
- **D** Pas le traitement de l'œdème cérébral.
- **E** Sans effet sur l'œdème.

③ **Perle** Réduire le débit de perfusion, intuber si défaillance respiratoire.

④ **Source** Phase B DX.9 §11 · LOT_003 audité

Q54 EX DX.10 · insuline

✅ **E** — Quand la glycémie cesse de baisser sous perfusion

① **Pourquoi c'est juste** SHH pur (DX.10) : le remplissage vient avant l'insuline ; l'hydratation abaisse déjà la glycémie. L'insuline à 0,05 UI/kg/h démarre quand la glycémie cesse de baisser, d'emblée si β-hydroxybutyrate 1,0 à 3,0 mmol/L.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Débit de l'acidocétose ; l'insuline précoce fait chuter volume et osmolalité.
- **B** Pas de bolus : l'hydratation prime.
- **C** Elle devient nécessaire quand la glycémie ne baisse plus.
- **D** Trop tard : elle démarre quand la glycémie stagne.

③ **Perle** β-hydroxybutyrate > 3,0 mmol/L ou pH < 7,3 : état mixte → protocole de l'acidocétose (0,1 UI/kg/h).

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_003 audité

Q55 EX DX.10 vs DX.9 · état mixte

✅ **D** — Protocole de l'acidocétose, 0,1 UI/kg/h

① **Pourquoi c'est juste** État mixte : hypovolémie, osmolalité ≥ 320, pH < 7,3, bicarbonate < 15, β-hydroxybutyrate > 3,0 mmol/L → protocole de l'acidocétose à 0,1 UI/kg/h. Un tiers des crises chevauchent acidocétose et SHH (DX.10, DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La cétonémie > 3,0 et l'acidose imposent le protocole de l'acidocétose.
- **B** Débit du SHH avec cétose légère (BHB 1,0 à < 3,0).
- **C** Pas dans une crise hyperglycémique.
- **E** Retard dangereux.

③ **Perle** Toujours : kaliémie avant insuline.

④ **Source** Phase B DX.10 §8 · LOT_003 audité

Q56 **AP** **DX.10 · vitesse**

✅ **B** — Trop rapide : la cible est 3 à 8 mOsm/kg par heure

① **Pourquoi c'est juste** Dans le SHH (DX.10) : osmolalité ↓ 3 à 8 mOsm/kg/h, glycémie ↓ 5 mmol/L/h au plus (5–6,7 selon les sources), natrémie ↓ ≤ 10 mmol/L en 24 h, pour éviter l'œdème cérébral.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une baisse rapide augmente le risque d'œdème cérébral.
- **C** 11 mOsm/kg/h dépasse la cible.
- **D** La vitesse d'osmolalité compte en elle-même.
- **E** La guérison est une osmolalité < 300 mOsm/kg.

③ **Perle** Une natrémie qui monte sous NaCl 0,9 % est attendue : soluté à 0,45 % seulement si l'osmolalité ne baisse plus.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_003 audité

Q57 **AP** **DX.10 · natrémie qui monte**

✅ **E** — Poursuivre le NaCl 0,9 %

① **Pourquoi c'est juste** L'hyperglycémie abaisse la natrémie mesurée ; quand la glycémie baisse, la natrémie remonte. Cette hausse est attendue : on passe au NaCl 0,45 % seulement si l'osmolalité ne baisse plus (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Seulement si l'osmolalité ne baisse plus.
- **B** Le volume n'est pas restauré.
- **C** Il s'ajoute sous 14 mmol/L de glycémie, pas pour la natrémie.
- **D** Sans indication.

③ **Perle** Natrémie corrigée de Hillier : + 0,024 × (glycémie mg/dL − 100).

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_003 audité

Q58 SPE · Médecine intensive DX.10 · thromboprophylaxie

✅ **B** — Énoxaparine 20 mg par jour

① **Pourquoi c'est juste** SHH (DX.10) : prophylaxie antithrombotique pendant tout le séjour ; Clexane® 40 mg par jour (AIPS), 20 mg si clairance < 30 mL/min.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Dose standard ; 20 mg si clairance < 30 mL/min.
- **C** Elle s'applique pendant tout le séjour.
- **D** Dose curative.
- **E** Pas la prophylaxie décrite.

③ **Perle** Examiner les pieds chaque jour : le SHH expose aux ulcères de pression.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_003 audité

Q59 EX DX.11 · ordre de substitution

✅ **D** — Glucocorticoïde avant lévothyroxine

① **Pourquoi c'est juste** En cas d'hypopituitarisme, l'insuffisance surrénalienne est exclue ou traitée avant de débuter la thyroxine (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'insuffisance surrénalienne se traite d'abord.
- **B** Le panhypopituitarisme impose la substitution complète.
- **C** Le glucocorticoïde vient en premier.
- **E** L'insuffisance corticotrope se traite sans attendre.

③ **Perle** Prévenir le patient : le cortisol peut démasquer ou aggraver la polyurie du déficit en AVP.

④ **Source** Phase B DX.11 §13 · LOT_003 audité

Q60 **EX** **DX.11 · après chirurgie hypophysaire**

✅ **C** — Natrémie et diurèse au moins quotidiennes

① **Pourquoi c'est juste** Après chirurgie hypophysaire : natrémie et diurèse au moins chaque jour (DX.11). Le déficit en AVP s'installe brutalement après chirurgie ou traumatisme.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le diabète insipide postopératoire s'installe vite.
- **B** Expose à l'hypernatrémie.
- **D** La surveillance est biologique et clinique.
- **E** Sans rapport.

③ **Perle** Score bâlois : antécédent de chirurgie hypophysaire = +50 en faveur du déficit en AVP.

④ **Source** Phase A §11.B.1 Lésion hypothalamo-hypophysaire · LOT_003 audité

Q61 **AP** **DX.11 vs DX.2 · natrémie de base**

✅ **D** — Premier : déficit en AVP ; second : polydipsie primaire

① **Pourquoi c'est juste** Cohorte bâloise (2025) : natrémie de base > 145 mmol/L → déficit en AVP (spécificité 100 %) ; < 135 mmol/L ou copeptine de base > 5,6 pmol/L → polydipsie primaire (spécificité 100 %) (DX.11, DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** C'est l'inverse.
- **B** Na > 145 désigne le déficit en AVP.
- **C** Na < 135 désigne la polydipsie primaire.
- **E** Elle a une spécificité de 100 % à ces seuils.

③ **Perle** Cette approche par étapes conclut chez 75 % des patients sans test dynamique.

④ **Source** Phase B DX.11 §8 · LOT_003 audité

Q62 SPE · Endocrinologie DX.11 · cortisol et polyurie

✅ **D** — Le cortisol démasque un déficit en AVP

① **Pourquoi c'est juste** La substitution en cortisol peut démasquer ou aggraver la polyurie du déficit en AVP : il faut en prévenir le patient (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La glycémie n'est pas en cause dans cette chronologie.
- **B** Le mécanisme connu est le démasquage du déficit en AVP.
- **C** Le cortisol n'induit pas de résistance rénale à l'AVP.
- **E** Aucun argument.

③ **Perle** Glucocorticoïde avant lévothyroxine.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_003 audité

Q63 AP DX.11 · desmopressine et vomissements

✅ **E** — Suspendre la desmopressine

① **Pourquoi c'est juste** Patient sous desmopressine qui vomit ou a de la fièvre : suspendre jusqu'au retour de l'équilibre hydrique (DX.11).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Risque d'hyponatrémie en cas de déséquilibre hydrique.
- **B** Il perd déjà de l'eau.
- **C** Traitement du néphrogénique.
- **D** La règle est de suspendre.

③ **Perle** Desmopressine orale contre-indiquée si clairance < 50 mL/min.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_003 audité

Q64 **EX** **DX.12 · déficit en eau**

✅ **A** — Environ 3,5 L

① **Pourquoi c'est juste** Déficit en eau = eau totale × (Na/140 − 1). Eau totale : 0,6 × poids (homme jeune), 0,5 (femme jeune, homme âgé), 0,45 (femme âgée). Ici 0,5 × 70 × 0,1 = 3,5 L (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Calcul avec 0,6 × poids (homme jeune) ; chez l'homme âgé, 0,5.
- **C** Sous-estimation : 0,5 × 70 × (154/140 − 1).
- **D** Calcul erroné.
- **E** La formule eau totale × (Na/140 − 1) s'applique.

③ **Perle** Remplacer sur 48 à 72 h par eau libre, orale ou glucose 5 %.

④ **Source** Phase B DX.12 §11 · LOT_003 audité

Q65 **EX** **DX.12 · vitesse de correction**

✅ **C** — Moins de 0,5 mmol/L/h, soit 12 mmol/L par jour

① **Pourquoi c'est juste** Hypernatrémie chronique (> 48 h) ou de durée inconnue : baisse < 0,5 mmol/L/h, soit 12 mmol/L par jour (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Admis seulement dans les 48 premières heures d'une forme aiguë, sur 6 à 8 h.
- **B** Trop rapide pour une forme chronique.
- **D** Trop lente : la correction trop lente aggrave le pronostic.
- **E** La forme chronique impose une limite.

③ **Perle** Natrémie toutes les 2 à 4 h au début.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_003 audité

Q66 EX DX.12 · noradrénaline

✅ **D** — Remplir d'abord : la noradrénaline seule est contre-indiquée

① **Pourquoi c'est juste** La noradrénaline ne remplace jamais le remplissage chez un patient hypovolémique : cristalloïde isotonique d'abord (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiquée seule dans l'hypotension par hypovolémie.
- **B** L'eau libre vient après la restauration du volume.
- **C** Contraire au besoin.
- **E** Sans indication.

③ **Perle** Dose initiale de noradrénaline, avec remplissage : 8 à 12 µg/min.

④ **Source** Phase B DX.12 §13 · LOT_003 audité

Q67 SPE · Médecine intensive DX.12 · correction trop lente

✅ **A** — Baisse lente (≤ 0,5 mmol/L/h) : mortalité à 30 jours 50,7 % vs 31,8 %

① **Pourquoi c'est juste** Cohorte de 4265 patients avec natrémie ≥ 155 mmol/L : baisse ≤ 0,5 mmol/L/h → mortalité à 30 jours 50,7 % ; baisse plus rapide → 31,8 %. Chez l'adulte hospitalisé, la correction rapide n'augmente pas la mortalité (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** C'est l'inverse.
- **C** La baisse lente s'associe à une mortalité plus élevée.
- **D** Pas le résultat rapporté.
- **E** Elle portait sur une natrémie ≥ 155 mmol/L.

③ **Perle** Ne pas corriger trop lentement non plus.

④ **Source** Phase B DX.12 §11 · LOT_003 audité

Q68 **AP** **DX.12 · pseudo-normonatrémie**

✅ **B** — Environ 148 mmol/L

① **Pourquoi c'est juste** Hillier : Na corrigée = Na + 0,024 × (glycémie mg/dL − 100) ; 136 + 0,024 × 500 = 148 mmol/L. Une hyperglycémie masque une hypernatrémie (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'hyperglycémie abaisse la natrémie mesurée.
- **C** La correction s'ajoute.
- **D** Calcul erroné.
- **E** Correction insuffisante.

③ **Perle** Glycémie en mmol/L × 18 = mg/dL.

④ **Source** Phase B DX.12 §8 · LOT_003 audité

Q69 **EX** **DX.13 vs DX.5 · PTH haute**

✅ **B** — Hyperparathyroïdie primaire

① **Pourquoi c'est juste** Une PTH élevée chez un cancéreux hypercalcémique oriente vers l'hyperparathyroïdie primaire (ou un cancer parathyroïdien), pas vers l'hypercalcémie maligne : un cancer connu n'exclut pas une hyperparathyroïdie (DX.13, DX.5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle s'accompagne d'une PTH basse.
- **C** PTH basse attendue.
- **D** PTH basse attendue.
- **E** PTH basse attendue.

③ **Perle** PTH basse = cause non parathyroïdienne : PTHrP, vitamine D, calcitriol, protéines.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_003 audité

Q70 EX DX.13 · zolédronate

✅ **E** — 4 mg IV unique, sur au moins 15 minutes

① **Pourquoi c'est juste** AIPS Zometa® (hypercalcémie maligne, calcémie corrigée > 3,0 mmol/L) : 4 mg en perfusion IV unique dans 100 mL de NaCl 0,9 % ou glucose 5 %, sur au moins 15 minutes, après contrôle de l'hydratation (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Durée minimale de 15 minutes.
- **B** Dose AIPS : 4 mg.
- **C** Voie et rythme erronés.
- **D** Dose du dénosumab.

③ **Perle** Contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement ; séparé des solutions calciques.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_003 audité

Q71 SPE · Oncologie DX.13 · insuffisance rénale

✅ **B** — Dénosumab, en surveillant l'hypocalcémie

① **Pourquoi c'est juste** Zolédronate déconseillé si DFGe < 30 mL/min ; le dénosumab reste possible en insuffisance rénale (hors AMM pour cette indication), avec un risque d'hypocalcémie : calcémie dans les 2 semaines (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Déconseillé si DFGe < 30 mL/min (AIPS).
- **C** Tachyphylaxie en 48 à 72 h.
- **D** Réservée à l'hypercalcémie par calcitriol.
- **E** Seulement en cas de surcharge.

③ **Perle** Calcium oral et vitamine D requis sous dénosumab, sauf en cas d'hypercalcémie.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_003 audité

Q72 SPE · Hématologie DX.13 · calcitriol

✅ **B** — Glucocorticoïde

① **Pourquoi c'est juste** Hypercalcémie par calcitriol (lymphome, granulomatose) : glucocorticoïde, car les antirésorptifs agissent mal (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** PTH basse : la parathyroïde n'est pas en cause.
- **C** Indiqué dans l'hyperparathyroïdie.
- **D** Aggraverait l'hypercalcémie.
- **E** Les thiazidiques élèvent la calcémie.

③ **Perle** PTHrP élevée = cause humorale (80 %) ; ostéolyse locale = 20 %.

④ **Source** Phase B DX.13 §10 · LOT_003 audité

Q73 AP DX.13 · calcitonine

✅ **C** — Tachyphylaxie : effet de 48 à 72 heures

① **Pourquoi c'est juste** La calcitonine n'agit que quelques jours (48 à 72 h) à cause de la tachyphylaxie : elle complète l'antirésorptif dans les formes sévères (> 3,5 mmol/L) (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** C'est le délai du bisphosphonate ; la calcitonine agit vite.
- **B** Elle est justement ajoutée dans les formes sévères.
- **D** Pas la limite décrite.
- **E** L'hydratation vient d'abord.

③ **Perle** Miacalcic® en crise : 5 à 10 UI/kg sur au moins 6 heures.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_003 audité

Q74 AP DX.13 · mécanisme

✅ **D** — Sécrétion de PTHrP

① **Pourquoi c'est juste** La PTHrP explique 80 % des hypercalcémies malignes ; l'ostéolyse locale 20 % (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas de métastase osseuse ; l'ostéolyse explique 20 % des cas.
- **B** Surtout lymphome et granulomatose.
- **C** PTH basse.
- **E** Elle n'élève pas la calcémie ainsi.

③ **Perle** Survie médiane : 52 jours dans les tumeurs solides — discuter tôt les soins palliatifs.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_003 audité

Q75 EX DX.2 🚩hors liste · convulsion

✅ **A** — Natrémie

① **Pourquoi c'est juste** Convulsion ou confusion chez un grand buveur d'eau : natrémie immédiate (hors liste, avant E1). Puis restriction hydrique ; NaCl 3 % si symptômes graves (DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'hyponatrémie se cherche en minutes ; l'imagerie après.
- **C** Ne change pas la conduite immédiate.
- **D** Test de la polyurie stable, jamais en urgence.
- **E** Utile s'il prend du lithium, mais la natrémie prime.

③ **Perle** Donner de l'eau ou de la desmopressine aggrave l'hyponatrémie.

④ **Source** Phase A Algorithme, étape 0 · LOT_003 audité

Q76 **EX** **DX.4 vs DX.2 · point brillant**

✅ **A** — Il manque aussi dans 39 % des polydipsies primaires

① **Pourquoi c'est juste** Le point brillant manque chez 70 % des diabètes insipides centraux et 39 % des polydipsies primaires : il ne tranche pas. La copeptine stimulée tranche (DX.4, DX.2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Il manque aussi dans 39 % des polydipsies primaires.
- **C** Il manque chez 70 % seulement.
- **D** Il reste présent chez 30 % des centraux.
- **E** Ce n'est pas un test diagnostique fiable.

③ **Perle** L'IRM cherche une lésion (E5), pas un diagnostic fonctionnel.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_003 audité

Q77 **EX** **DX.9 · bicarbonate**

✅ **C** — Non : le bicarbonate est réservé au pH < 7,0

① **Pourquoi c'est juste** Acidocétose (DX.9) : bicarbonate seulement si pH < 7,0 (100 mmol dans 400 mL d'eau stérile toutes les 2 h). Perfusion, potassium, insuline restent l'ordre.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le critère est le pH < 7,0.
- **B** Seulement si pH < 7,0.
- **D** L'insuline éteint la cétogenèse.
- **E** Le remplissage vient d'abord.

③ **Perle** Phosphate : seulement si phosphatémie < 1,0 mmol/L avec faiblesse.

④ **Source** Phase B DX.9 §14 · LOT_003 audité

Q78 EX DX.9 · euglycémique

✅ **E** — Acidocétose euglycémique

① **Pourquoi c'est juste** Environ 10 % des acidocétoses sont euglycémiques (jeûne, grossesse, inhibiteurs du SGLT2). Le diabète connu remplace le critère glycémique (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La glycémie normale n'exclut pas l'acidocétose.
- **B** pH 7,21 et BHB ≥ 3,0 : acidocétose.
- **C** Glycémie basse, cétose forte.
- **D** La cétonémie explique l'acidose.

③ **Perle** Mesurer cétones et pH même si la glycémie est normale.

④ **Source** Phase A §4 Drapeaux rouges, E1 · LOT_003 audité

Q79 AP DX.9 · bandelette

✅ **B** — Bandelette trompeuse : suivre le BHB sanguin

① **Pourquoi c'est juste** La bandelette urinaire mesure l'acétoacétate, pas le β-hydroxybutyrate : elle sous-estime la cétose au début et la surestime ensuite. On suit le BHB sanguin (DX.9).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La bandelette surestime la cétose en phase de guérison.
- **C** Sans rapport.
- **D** Seul un pH < 7,0 l'indique.
- **E** La sortie se juge sur BHB < 0,6 et pH ≥ 7,3.

③ **Perle** Le trou anionique ne sert ni au diagnostic ni à la guérison.

④ **Source** Phase B DX.9 §8 · LOT_003 audité

Q80 **EX** **DX.8 · lopéramide**

✅ **B** — Lopéramide

① **Pourquoi c'est juste** Le lopéramide est contre-indiqué en cas de diarrhée sanglante avec fièvre (dysenterie) : il aggrave la colite (DX.8).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Appropriée : première intention sans choc.
- **C** Appropriée devant une diarrhée sanglante fébrile.
- **D** Approprié devant une dysenterie.
- **E** Appropriée en cas de déshydratation.

③ **Perle** Drapeau rouge : sang dans les selles + fièvre élevée.

④ **Source** Phase B DX.8 §13 · LOT_003 audité

Q81 **EX** **DX.5 vs DX.13 · furosémide**

✅ **E** — Non : réhydrater d'abord ; furosémide seulement si surcharge

① **Pourquoi c'est juste** La crise hypercalcémique se traite d'abord par la réhydratation salée ; le furosémide vient seulement en cas de surcharge cardiaque ou rénale (DX.5, DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La réhydratation salée vient d'abord.
- **B** Le patient hypercalcémique est déshydraté.
- **C** Il ne freine pas la résorption osseuse.
- **D** Les thiazidiques élèvent la calcémie.

③ **Perle** L'hypercalcémie rend le tubule résistant à l'AVP : le patient est polyurique et déshydraté.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_003 audité

Q82 EX DX.7 · restriction sous lithium

✅ **B** — Non : la déshydratation pousse à l'intoxication au lithium

① **Pourquoi c'est juste** Un patient sous lithium ne subit pas de restriction hydrique thérapeutique : la déshydratation pousse à l'intoxication. Seul un test diagnostique hospitalier surveillé reste possible (DX.7).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Elle ne corrige pas la résistance rénale.
- **C** Pas de restriction thérapeutique sous lithium.
- **D** La desmopressine est inefficace ici.
- **E** Seul un test hospitalier surveillé reste possible.

③ **Perle** Lithiémie ≥ 1,5 mmol/L : arrêt immédiat.

④ **Source** Phase B DX.7 §13 · LOT_003 audité

Q83 EX DX.13 · calcium total

✅ **E** — Calcémie corrigée ou calcium ionisé

① **Pourquoi c'est juste** Le calcium total trompe si l'albumine est basse (myélome, dénutrition) : utiliser la calcémie corrigée par l'albumine ou le calcium ionisé (DX.13).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le calcium total trompe si l'albumine est basse.
- **B** Sans rapport.
- **C** Contre-indiquée en cas d'hypercalcémie.
- **D** Dangereux si l'hypercalcémie est confirmée.

③ **Perle** 38 % des sorties ne mentionnent pas une hypercalcémie : elle échappe au diagnostic.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_003 audité

Q84 **AP** **DX.12 · glucose 5 %**

✅ **E** — Le glucose 5 % ne doit jamais être le seul apport liquidien

① **Pourquoi c'est juste** AIPS glucose 5 % : maximum 40 mL/kg/j et 5 mL/kg/h ; contre-indiqué comme seul apport liquidien journalier ; prudence si la fonction rénale est altérée (DX.12).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il apporte l'eau libre ; il n'est simplement jamais seul.
- **B** Aggraverait l'hypernatrémie.
- **C** Il en apporte après métabolisation.
- **D** L'AIPS le contre-indique comme seul apport.

③ **Perle** Choc d'abord (cristalloïde isotonique), eau libre ensuite.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_003 audité

Q85 **AP** **DX.1 · HbA1c trompeuse**

✅ **D** — Doser la glycémie veineuse

① **Pourquoi c'est juste** L'HbA1c n'est pas fiable en cas d'anémie ou d'hémoglobinopathie ; les critères glycémiques (à jeun ≥ 7,0, aléatoire ≥ 11,1 avec symptômes, HGPO) prennent le relais (DX.1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Non fiable en cas d'anémie ou d'hémoglobinopathie.
- **B** Le chiffre n'est pas interprétable.
- **C** On écarte d'abord un soluté par la glycémie.
- **E** Après avoir écarté glucose, calcium et rein.

③ **Perle** Seule la glycémie sépare le diabète insipide du diabète sucré.

④ **Source** Phase B DX.1 §8 · LOT_003 audité